# UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

(CREADA POR LEY Nº25265)

## FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

## PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

## TESIS

# RESULTADOS MATERNO PERINATALES E INDICE DE CESAREAS EN PUÉRPERAS CON PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2019

## LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

**SALUD MATERNO PERINATAL Y NEONATAL**

## PRESENTADO POR:

Obsta. LAURENTE ARANA, ROXANA
Obsta. QUIÑONEZ INGA, MAGALLY

## PARA OPTAR EL TITULO DE ESPECIALISTA EN:

## PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA Y ESTIMULACIÓN PRENATAL CON ADECUACIÓN INTERCULTURAL

**HUANCAVELICA – PERÚ**

**2023**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA**
(Creada por Ley N° 25265)

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

# ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Huancavelica a las 11:30 horas del día nueve de junio del año dos mil veintitrés, nos reunimos los miembros del Jurado Evaluador, designado con Resolución N°0272-2023-D-FCS-R-UNH, de fecha 19 de mayo del 2023, conformado de la siguiente manera:

Presidente : Dra. LINA YUBANA CÁRDENAS PINEDA
https://orcid.org/0000-0001-5715-7031
DNI N°: 20059866

Secretario : Dra. CLARIS JHOVANA PÉREZ VENEGAS
https://orcid.org/0000-0002-9114-3538
DNI N°: 80078866

Vocal : Mg. CESIA REBECA ZARATE CACERES
https://orcid.org/0000-0001-6168-5574
DNI N° 42315665

Con la finalidad de llevar a cabo el acto académico de sustentación de la tesis de segunda especialidad en Psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal con adecuación intercultural, titulada: **RESULTADOS MATERNO PERINATALES E INDICE DE CESAREAS EN PUÉRPERAS CON PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2019.** aprobada mediante Resolución N°322-2023-D-FCS-R-UNH, donde se fija fecha y hora para el mencionado acto.

**Sustentante(s):**
**LAURENTE ARANA, ROXANA**
**DNI N°:** 42063855
**QUIÑONEZ INGA, MAGALLY**
**DNI N°:** 44127780

**Asesor:**
Dra. ROSSIBEL JUANA MUÑOZ DE LA TORRE
https://orcid.org/0000-0003-1544-8863
DNI N°: 42145123

Concluida la sustentación de forma presencial, se procede con las preguntas y/u observaciones por parte de los miembros del jurado. Acto seguido, el presidente del Jurado Evaluador informa a las sustentantes que se procede a deliberar los resultados de la sustentación de la tesis; llegando al calificativo de: **APROBADO** por **UNANIMIDAD**.

Para constancia se expide la presente Acta, en la ciudad de Huancavelica a los nueve días del mes de junio del 2023.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Dra. Lina Y. CÁRDENAS PINEDA
DOCENTE NOMBRADA
PRESIDENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Dra. Claris J. Pérez Venegas
DOCENTE
SECRETARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Mg. Cesia R. Zárate Cáceres
DOCENTE
VOCAL

# TITULO

RESULTADOS MATERNO PERINATALES E INDICE DE CESAREAS EN GESTANTES CON Y SIN PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2019

**AUTORES**

LAURENTE ARANA, ROXANA

QUIÑONEZ INGA, MAGALLY

ASESORA

Dra. ROSSIBEL JUANA MUÑOZ DE LA TORRE

**ORCID:** https://orcid.org/0000-0003-1544-8863

**DNI N.°** 42145123

# DEDICATORIA

A mis padres: Lino y Dolia, por su constancia en mi crecimiento profesional.

A mis amados: Marvin, Margareth y Milán , fuente de inspiración a ser mejor persona.

Magally

A mis padres: Nazario y Leandra, quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y su gran apoyo incondicional.

A mi hija: Dasha Priyana, por la fortaleza y motivación para seguir adelante.

Roxana

# AGRADECIMIENTO

A todos los docentes de la segunda especialidad en Psicoprofilaxis obstétrica con adecuación intercultural, quienes contribuyeron en nuestra etapa de formación como especialistas.

A los directivos y obstetras del Hospital Departamental de Huancavelica por las facilidades brindadas para concretar con el presente estudio.

A todas nuestras colegas obstetras, quienes de alguna forma motivaron al logro del presente.

**INDICE**

ACTA DE SUSTENTACIÓN ..... ii
DEDICATORIA ..... v
AGRADECIMIENTO ..... vi
ASESORA ..... vii
INDICE DE TABLAS ..... x
RESUMEN ..... xi
ABSTRACT ..... xii
**INTRODUCCION** ..... xiii
**CAPÍTULO I** ..... 14
**PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA** ..... 14
**1.1. Descripción del problema** ..... 14
**1.2. Formulación del problema** ..... 15
**1.2.1. Problema general** 15
**1.2.2. Problemas específicos** 16
**1.3. Objetivos de la investigación** ..... 16
**1.3.1. Objetivo general** 16
**1.4. Justificación** ..... 17
**1.5. Limitaciones** ..... 17
**CAPÍTULO II** ..... 18
**MARCO TEÓRICO** ..... 18
**2.1. Antecedentes de la investigación** ..... 18
**2.2. Bases teóricas** ..... 24
**2.3. Definición de términos** ..... 48
**2.4. Hipótesis** ..... 48
**2.5. Variables** ..... 48
**2.6. Operacionalización de variables** ..... 48
**CAPÍTULO III** ..... 52
**METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN** ..... 52
**3.1. Ámbito temporal y espacial** ..... 52
**3.2. Tipo de investigación** ..... 52
**3.3. Nivel de investigación** ..... 53
**3.4. Métodos de investigación** ..... 53

**3.4.1. Método general** ..... 53
**3.4.2. Método específico** ..... 53
**3.5. Diseño de investigación** ..... 53
**3.6. Población, muestra y muestreo** ..... 54
**3.6.1. Población** ..... 54
**3.6.2. Muestra** ..... 54
**3.6.3. Muestreo** ..... 55
**3.7. Técnicas e instrumentos para recolección de datos** ..... 55
**3.8. Técnica y procesamiento de análisis de datos** ..... 56
**CAPÍTULO IV** ..... 57
**PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS** ..... 57
**4.1. Análisis de información** ..... 57
**4.2. Prueba de hipótesis** ..... 64
**4.3. Discusión de resultados** ..... 64
**CONCLUSIONES** ..... 68
**RECOMENDACIONES** ..... 69
**ANEXOS** ..... 75
**ANEXO A:Matriz de consistencia** ..... 76
**ANEXO B: Instrumento de Recolección de datos** ..... 79
**ANEXO C:Validación del instrumento de investigación** ..... 82

# INDICE DE TABLAS


| | | Pg. |
|---|---|---|
| Tabla 1 | Características sociodemográficas de las puérperas post cesárea con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019. | 55 |
| Tabla 2 | Resultados materno perinatales en puérperas post cesárea con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019. | 58 |
| Tabla 3 | Grupos de cesárea frecuentes en las puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019. | 60 |

# RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar los resultados materno perinatales e índice de cesárea en puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019. La metodología, fue un estudio con enfoque cuantitativo, observacional, no experimental con un diseño descriptivo comparativo desarrollado en una población y muestra de 72 puérperas distribuidas en dos grupos pareados según edad de 36 puérperas cada grupo, cuyos datos fueron analizados con la prueba de chi cuadrado de homogeneidad. Los resultados obtenidos fueron las características sociodemográficas que difieren en ambos grupos son el nivel de instrucción superior que prima en las que asistieron (47.2%) a PPO y nivel secundario en las que no asistieron (50.0%); sin embargo el estado civil conviviente fue del 75.0% vs 83.3%, atenciones prenatales mayores a 6 el 86.1% frente al 58.4%; la paridad primípara el 61.1% frente al 44.4%; con cesárea previa el 8.3% frente al 16.7% y parto a término el 91.6% frente al 94.4%. Los resultados materno perinatales diferentes estadísticamente significativa fue el inicio del parto espontáneo en puérperas con psicoprofilaxis 69.4% frente al 38.9% en puérperas sin PPO, hubo dilataciones estacionarias e irregulares del 38.9% con PPO y el 61.1% sin PPO más no hubo diferencias significativas; el Apgar fue normal en ambos grupos 100.0% frente al 97.2% y el contacto precoz fue de 83.3% con PPO frente al 69.4% sin PPO. El grupo de cesáreas según la escala Robson de mayor frecuencia fueron el grupo I del 30.6% frente al 27.8% sin PPO, seguido del grupo II 25.0% frente al 16.7%. En conclusión, solo el resultado materno perinatal inicio de parto espontáneo fueron diferentes en ambos grupos.

**Palabras clave:** índice de Robson, Psicoprofilaxis obstétrica, resultado materno perinatal

# ABSTRACT

The objective of this study was to determine the maternal and perinatal outcomes and the caesarean section rate in puerperal women with and without obstetric psychoprophylaxis, treated at the Departmental Hospital of Huancavelica, 2019. The methodology was a study with a quantitative, observational, non-experimental approach with a design comparative descriptive study developed in a population and sample of 72 puerperal women distributed in two age-matched groups of 36 puerperal women each group, whose data were analyzed with the chi-square test of homogeneity. The results obtained were the sociodemographic characteristics that differ in both groups are the level of higher education that prevails in those who attended (47.2%) to PPO and secondary level in those who did not attend (50.0%); however, the cohabiting marital status was 75.0% vs. 83.3%, prenatal care older than 6 was 86.1% vs. 58.4%; primiparous parity 61.1% compared to 44.4%; 8.3% with previous caesarean section vs. 16.7% and 91.6% delivery at term vs. 94.4%. The statistically significant different perinatal maternal results were the start of spontaneous labor in puerperal women with psychoprophylaxis 69.4% versus 38.9% in puerperal women without PPO, there were stationary and irregular dilations of 38.9% with PPO and 61.1% without PPO plus there were no significant differences; the Apgar was normal in both groups 100.0% versus 97.2% and early contact was 83.3% with PPO versus 69.4% without PPO. The most frequent group of cesarean sections according to the Robson scale were group I of 30.6% compared to 27.8% without PPO, followed by group II 25.0% compared to 16.7%. In conclusion, only the perinatal maternal outcome onset of spontaneous labor was different in both groups.



**Keywords:** robson index, obstetric psycoprophylaxis, maternal perinatal outcome.

# INTRODUCCION

Es conocido que las mujeres temen al trabajo de parto, confiriendo en una carga emocional negativa estimulando a la acentuación de dolores, la misma que puede repercutir en la dinámica uterina y por ende en el incremento de cesáreas innecesarias.

La psicoprofilaxis obstétrica es la preparación integral, teórica, física y psicoactiva que se brinda en el embarazo, parto y puerperio para alcanzar resultados maternos aceptables, mejorando las condiciones en que estas se desarrollan (5), convirtiéndose en Perú en una herramienta de prevención en la atención obstétrica por los resultados de gran impacto además de lograr hábitos y comportamientos saludables (9,10).

En Perú, sin embargo, las cesáreas se han incrementado superando la tasa promedio y no se observó que ayude en la disminución de la mortalidad materna y neonatal; por otro lado, la salida de la pandemia ha permitido reactivar gradualmente el programa de psicoprofilaxis obstétrica aunque con grandes limitaciones en su implementación aún no se toma en cuenta los grandes beneficios que ella trae consigo.

El Hospital Departamental de Huancavelica, brinda el servicio de psicoprofilaxis obstétrica acorde a la guía del Ministerio de salud; sin embargo, algunas gestantes preparadas culminan el parto por cesárea, generando vacíos del conocimiento en los beneficios y resultados materno perinatales de la educación materna.

El estudio tiene como objetivo determinar los resultados materno perinatales y la identificación del grupo de cesáreas frecuentes según la escala Robson, por lo que la hipótesis propuesta fue existe diferencias entre los resultados y grupos de cesáreas en puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica.

El informe se organizó en cuatro capítulos que abordan desde el planteamiento del problema, objetivos y justificación, luego el Marco teórico enfatizando los antecedentes de estudio y definición conceptual de variables, luego la metodología abordada en el presente estudio y finalmente los resultados, la discusión y conclusiones.

Las autoras

# CAPÍTULO I

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## 1.1. Descripción del problema

La psicoprofilaxis obstétrica es la preparación integral, teórica, física y psicoactiva que se brinda en el embarazo, parto y puerperio para alcanzar resultados maternos aceptables, mejorando las condiciones en que estas se desarrollan (1), en otros países como Argentina, España es conocida como educación antenatal (2, 3).

El Colegio Americano de ginecología y obstetricia avalan el uso de la psicoprofilaxis obstétrica por su impacto en el desenlace del embarazo (4) y porque disminuye las complicaciones materno perinatales al acortar el tiempos del proceso del parto y mejorar la oxigenación del feto y la madre (5, 6), la tasa de cesáreas en gestantes con esta intervención fue de 7.5% comparado al 27.3% en las no intervenidas, presencia de patologías en 17.5% frente al 43.7%, es decir reduce las intervenciones rutinarias e innecesarias durante el embarazo y parto (7). Además que una educación en psicoprofilaxis adecuada, el temor desaparece y es reemplazado por el sentimiento inherente a la maternidad (8).

En Ecuador, se obtuvo resultados materno perinatales positivos acerca de la psicoprofilaxis obstétrica, convirtiéndose en Perú en una herramienta de prevención en la atención obstétrica por los resultados de gran impacto además de lograr hábitos y comportamientos saludables (9, 10),

Sin embargo, indistintamente de la condición de las gestantes hoy por hoy se ha incrementado las cesáreas; tal es así que, el índice de cesáreas a nivel mundial desde el 2015 es del 15 al 19% (11), pudiendo identificarse los grupos de parturientas que culminaron en cesáreas innecesarias a través del índice de Robson (12), dado que cuando la mujer desconoce las fases del parto ingresa tempranamente al establecimiento de salud, donde se ha demostrado la gran susceptibilidad a recibir intervenciones innecesarias como la conducción del parto con oxitócicos e incluso la cesárea (2, 13).

Está sustentado que, con una tasa de cesárea del 10% la mortalidad materna y neonatal disminuyó; a medida que las cesáreas superaban esta tasa no se observó ningún efecto sobre la mortalidad (14), surgiendo la necesidad de hacer seguimiento sobre la tasa de cesárea en los establecimientos sanitarios.

El Hospital Departamental de Huancavelica, brinda el servicio de psicoprofilaxis obstétrica acorde a la guía del Ministerio de salud; sin embargo, algunas gestantes preparadas culminan el parto por cesárea, generando vacíos del conocimiento en los beneficios y resultados materno perinatales de la educación materna.

A pesar del mejorar el acceso a la atención prenatal, aún el servicio de psicoprofilaxis obstétrica no tiene la acogida de todas las gestantes; sin embargo, a través del estudio se pretende conocer en este grupo los resultados materno perinatales y el grupo de cesáreas frecuentes según la escala de Robson para difundir los resultados en el establecimiento de salud y establecer estrategias, políticas de salud en psicoprofilaxis obstétrica.

## 1.2. Formulación del problema

### 1.2.1. Problema general

¿Cuáles son los resultados materno perinatales e índice de cesárea en puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019?

### 1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019?
- ¿Cuáles son los resultados materno perinatales en las puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019?
- ¿Cuál es el índice de cesáreas en las puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019?

## 1.3. Objetivos de la investigación

### 1.3.1. Objetivo general

Determinar los resultados materno perinatales e índice de cesárea en puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019.

### 1.3.2. Objetivos específicos

- Describir las características sociodemográficas de las puérperas post cesárea con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019.
- Determinar los resultados materno perinatales en las puérperas post cesárea con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019.
- Identificar el grupo de cesáreas frecuentes en las puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019.

## 1.4. Justificación

La psicoprofilaxis obstétrica es un proceso educativo cuyo fin es obtener una actitud positiva en la parturienta, pareja y familia frente al embarazo, parto y puerperio en beneficio de la salud materna y perinatal, previniendo situaciones desfavorables.

Estudios diversos desde hace muchos años demuestran que los programas de psicoprofilaxis obstétrica sirvieron para encontrar un número reducido de nacidos pretérminos, trabajos de partos breves, menos partos quirúrgicos y madres felices (15, 16); así mismo, es considerado como una herramienta de atención integral con impacto positivo en el binomio madre niño cuyo profesional obstetra está capacitado para educar e intervenir en las gestantes con resultados favorables.

Por otro lado, estudios reportan el incremento de las cesáreas más allá de lo permitido entre ellas se incluyen a gestantes con psicoprofilaxis obstétrica, cuya indicación aún es desconocida o incoherente con los hallazgos (17).

En el Hospital Departamental de Huancavelica, se viene ofertando el servicio de psicoprofilaxis obstétrica desde hace años con estudios que reflejan los beneficios; sin embargo, también la frecuencia de cesáreas en los últimos años está incrementada, por tanto los resultados materno perinatales e índice de cesáreas en este grupo de parturientas aún se desconocen.

Los resultados del presente estudio permiten ampliar conocimientos actualizados, evitar cesáreas innecesarias, el ahorro de recursos hospitalarios buena administración del tiempo y personal. Además de servir de base para estudios de mayor complejidad.

## 1.5. Limitaciones

Carece de validez externa, los resultados son válidos para el contexto estudiado.

# CAPÍTULO II

# MARCO TEÓRICO

## 2.1. Antecedentes de la investigación

### Internacional

Zapata (18). Miedo al parto como factor de aumento en el índice de cesáreas. El objetivo fue conocer si el miedo se asocia a fatores sociodemográficos y médico obstétricos en gestantes del tercer trimestre antes del parto, 2020. La metodología comprende estudio longitudinal, comparativo observacional, donde se aplicó 250 encuestas en el área Materno de un Hospital Universitario, se evaluó el miedo por medio de la escala W-DEQ, se comparó el miedo antes y después del parto. Los resultados fueron edad promedio de 23.1 ± 5 años, primigestas el 53.7% y multigestas el 46.3%, cuya prevalencia del miedo fue de 0.5% antes del embarazo. En conclusión la prevalencia de miedo al parto es baja, disminuyendo posterior al parto, siendo las primigestas las que mayor temor tuvieron.

Déctor (19). Evaluation of psychoprophylaxis and continuous emotional support to decrease the Caesarean Index, 2019. El objetivo es Evaluar la relación entre la psicoprofilaxis y el soporte emocional continuo para reducir el índice de cesáreas. La metodología, se evaluaron 380 mujeres con embarazos a término y trabajo de parto en fase activa en el Nuevo Sanatorio Durango en el periodo de junio de 2015 a junio de 2016. La evaluación incluye soporte emocional, para reducir el estrés de la cesárea. Los resultados, la psicoprofilaxis favorece el soporte emocional, reducción de oxitocina y

analgésicos disminuyendo el índice de cesárea. En conclusión, la psicoprofilaxis obstétrica reduce el uso de oxitocina e índice de cesáreas.

Elizalde (20). Estudio comparativo del índice de cesáreas efectuado en el servicio de Ginecología y Obstetricia de Hospital de Alta Especialidad Ixtapaluca Vs la clasificación de Robson. El objetivo fue comparar el índice de cesáreas en primigestas en la clínica con el índice de Robson; el estudio fue observacional, retrospectivo dividido en tres grupos etarios : adolescentes, adultas y adultos mayores. Los resultados fue el 43% de Cesáreas en la clínica y el 39% de la población total; solo el 21% cumplían indicaciones siendo el más frecuente el sufrimiento fetal. En conclusión, las cesáreas van de acuerdo van de la mano con las diferentes características por lo que la recomendación de la OMS no puede ser usada en el 15% dando la oportunidad de establecer el índice de porcentajes.

Regalado (21). Psicoprofilaxis durante el embarazo para mejorar el proceso y resultados durante el trabajo de parto y de las condiciones del neonato El objetivo fue evaluar la psicoprofilaxis obstétrica durante el embarazo para mejorar os resultados del trabajo de parto en el Centro de Salud Augusto Egas en Santo Domingo de Tsachilas, Ecuador - 2017. La metodología utilizada fue un estudio comparativo, retrospectivo o histórico, el estudio se desarrolló en dos grupos de expuestas y no expuestas, es decir las que asistieron total o parcialmente a la practicas de psicoprofilaxis obstétrica en diferentes centros de salud y no expuestas las que nunca asistieron a las sesiones, sumados en total 995 parturientas. Los resultados fueron 91 parturientas con PPO y 904 sin PPO; los tiempos de la dilatación en las que hicieron PPO fue menor en el 49.4% frente al 39% sin PPO; los desgarros perineales se presentó en el 5.4% de las que recibieron PPO frente al 15% de las que no asistieron a PPO, con un p-valor de 0.008; hubo necesidad de conducción de parto en el 6.5% de las que recibieron PPO frente al 11% en las que no recibieron. En conclusión, las que recibieron PPO no tuvieron inconvenientes, logrando disminuir el tiempo en las fases latente, expulsivo y alumbramiento además que los desgarros perineales también disminuyeron.

## Nacional

Coaquira (22). Relación de la psicoprofilaxis obstétrica con los resultados obstétricos neonatales y en la salud mental perinatal de primigestas del Hospital de la Ciudad del Cusco - 2020. El objetivo fue determinar la relación de la psicoprofilaxis obstétrica con los resultados obstétricos, neonatales y de salud mental de primigestas en los Hospitales de la ciudad Cusco. La metodología fue un estudio analítico, transversal realizado en 81 puérperas con parto vaginal siete días antes del estudio. Los resultados fueron que las gestantes recibieron entre 1 a 6 sesiones de PPO, con un promedio de 3 sesiones; el estado civil fue con pareja el 81.6% frente al 80.25% de las que no tenían PPO; sin diferencias estadísticas en los tiempos de los periodos del parto y la preparación psicoprofiláctica. En conclusión la psicoprofilaxis obstétrica fue un factor protector para conducción del parto y síndrome de estrés postraumático.

Ocrospoma (23). Estudios comparativo de los beneficios maternos y perinatales durante el trabajo de parto de pacientes que acudieron y no acudieron al programa de Psicoprofilaxis obstétrica del Hospital Nacional Hipólito Unanue – 2017. El objetivo fue comparar los beneficios materno-perinatales durante el parto en gestantes con y sin preparación en psicoprofilaxis obstétrica. La metodología fue estudio descriptivo comparativo, retrospectivo y de corte transversal. Los resultados hallados en gestantes preparadas frente a gestantes sin PPO fueron de edades entre 21 a 25 años el 335 frente al 39%, convivientes el 77% frente al 70%, amas de casa el 40% frente al 70%; los controles prenatales mayor a 6 fue 100% frente al 47%; siendo el periodo de dilatación de 8 a 14 horas en el 97% frente al 43%, el periodo expulsivo menor a 30 minutos el 97% frente al 50%; presentaron preeclampsia el 3% frente al 10%, partos vaginales el 97% frente al 83%, inicio de parto espontáneo el 97% frente al 43%, partos acentuados el 0% frente al 33%, lesión perineal el 27% frente al 60%; episiotomía el 27% frente al 13%; peso del neonato normal en el 100% frente al 80%; Apgar normal 100% frente al 73%; contacto piel a piel 100% frente al 67%. En conclusión, Existen

beneficios materno y perinatales en las pacientes que recibieron psicoprofilaxis obstétrica.

Daza (24). Características del parto y el recién nacido en parturientas que recibieron psicoprofilaxis obstétrica. El objetivo fue identificar las características del parto y el recién nacido en parturientas preparadas durante el año 2019. La metodología fue un estudio descriptivo simple, retrospectivo, observacional, analítico de nivel exploratorio ejecutado en 35 parturientas con seis sesiones en psicoprofilaxis obstétrica. Los resultados indican que el 85.7% culminaron el parto vía vaginal de las cuales al 66.7% se le realizó la episiotomía y el 14.3% cesárea programada por macrosomía fetal, desproporción cefalopélvica y presentación podálica; las edades fueron entre 18 a 35 años el 88.6% y menores de 18 años el 11.4%, al ingreso las parturientas tenían entre 0 a 3 de dilatación el 76.7% y solo el 23.3 en fase activa de labor de parto. La labor del parto duró menos de 10 horas en el 86.7%; el 13.3% presentó desgarros y distocia funicular. Los neonatos tuvieron pesos normales en el 100% sin complicaciones. En conclusión, la psicoprofilaxis fue importante para obtener resultados favorables en la labor de parto; así mismo, las cesáreas fueron innecesarias.

Mamani (25). Preparación en psicoprofilaxis obstétrica y los resultados materno perinatales en parturientas del Centro Materno Infantil Cesar López Silva, Lima 2019. El objetivo fue relacionar la preparación en psicoprofilaxis obstétrica; la metodología utilizada fue un estudio descriptivo correlacional de diseño no experimental transversal, se aplicó una ficha de recolección de datos a 280 parturientas con y sin psicoprofilaxis obstétrica distribuidas de forma proporcional. Los resultados hallados fueron el 37.5% culminó las sesiones, 12.5% tuvo sesiones incompletas y 50% no desarrollaron las sesiones; la duración de los periodos del trabajo de parto fue menor en las gestantes preparadas, la dilatación en el 37.5% de las nulíparas fue menor a 8 horas y el 35.2% de las multíparas tuvo menos de 6 horas; el periodo expulsivo en las gestantes preparadas también fue menor, las 35.7% de nulíparas menos de 5 minutos y 41.9% de multíparas menor de 20 minutos; el desgarro perineal I

grado se presentó solo en el 32.95 de las nulíparas. El puntaje Apgar fue mejor en comparación con las no preparadas; el peso del neonato en puérperas fue normal en el 48.9% de las puérperas preparadas frente al 45% en las no preparadas. En conclusión, existe relación entre la preparación psicoprofilaxis obstétrica y los resultados materno perinatales.

Osorio (26). Efecto de la asistencia a sesiones de psicoprofilaxis obstétrica sobre sobre los indicadores materno-perinatales en pacientes del Hospital Sergio Bernales-2017. El objetivo fue determinar el efecto de la psicoprofilaxis obstétrica sobre los indicadores materno-perinatales en el primer trimestre del 2017. La metodología fue un estudio de enfoque cuantitativo descriptivo comparativo, retrospectivo, el estudio tuvo dos grupos conformados de 45 gestantes que habían recibido todas las sesiones y el otro grupo también de 45 que asistieron a menos de tres sesiones. Los resultados fueron el 71% de las pacientes que asistieron a 6 sesiones tenían entre 20 a 35 años de edad y 64.4% del otro grupo entre 15 a 19 años; de nivel secundario el 75.6% y 77.8% respectivamente, convivientes el 68.9% y 57.8% y primíparas el 73.3% y 100%; la duración del trabajo de parto en grupo de asistencia a seis sesiones frente al grupo de asistencia menor a 3 sesiones se expresaron en: dilatación menor a 6 horas 80% frente al 100% entre 6 a 8 horas, el periodo expulsivo en primíparas fue menor a 50 minutos en el primer grupo frente al 97.7%; en el caso de las multíparas fue menor a 20 minutos el 80% y en el otro grupo mayor a 20 minutos el 50%, peso del neonato normal el 86.7% frente 91.1%, el puntaje Apgar en ambos grupos fueron normales; el contacto piel a piel fue 93.3% frente al 84.4%. En conclusión, la duración del periodo de dilatación y expulsivo en multíparas fueron significativamente menor en pacientes con sesiones completas en psicoprofilaxis obstétrica con respecto a las que asistieron en menos de 3 sesiones.

Yábar (16). La psicoprofilaxis obstétrica (PPO) en gestantes adolescentes: características y beneficios integrales. El objetivo fue conocer las características y beneficios de la PPO en las adolescentes en Lima, 2017. La metodología fue un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, observacional,

transversal con 38 gestantes adolescentes de una consulta privada en la ciudad de Lima, tomando en cuenta los criterios de elección como siete controles prenatales, asistencia de 6 a 8 sesiones de PPO, hospitalización en fase activa y actitud positiva a la llegada del bebé. Los resultados encontrados fueron que las gestantes que recibieron PPO mostraron mayor interés y responsabilidad en la asistencia en las sesiones, el 97.3% recibieron más de siete controles prenatales, 100% de 6 a 8 sesiones, el 86.4% ingresaron en fase activa de labor de parto, el mismo porcentaje tuvo parto vaginal, el 39.4% tuvo actitud positiva al inicio de las sesiones invirtiéndose al 1005 al finalizar el embarazo y sesiones.

García (27). Influencia de la psicoprofilaxis obstétrica en la prevención de complicaciones maternas y neonatales de los partos atendidos en el Hospital Regional de Loreto – 2016. El objetivo fue determinar la influencia de la psicoprofilaxis obstétrica en la prevención de patologías materno-neonatales. La metodología fue enfoque cuantitativo, de tipo observacional, retrospectivo con diseño de casos y controles desarrollado en 60 gestantes que culminaron las seis sesiones y el grupo control conformado por 120 gestantes sin psicoprofilaxis obstétrica. Los resultados fueron disminuir el bajo peso al nacer en el 82%, reduce la probabilidad de prematuridad en el 70%; en el caso de las complicaciones se pudo apreciar que de 20 preeclampsias, 15 fueron severas y solo 2 de ellas asistieron a psicoprofilaxis obstétrica; 5 tuvieron preeclampsia leve y ninguna hizo PPO; el 14.4% tuvo desgarros tipo I y II. En conclusión la psicoprofilaxis no está relacionada con la vía del parto debido a que 21 gestantes de 58 que asistieron a psicoprofilaxis terminaron en cesárea pero no se pudo demostrar la prevención de la rotura uterina porque no hubo casos; sin embargo, es un factor protector de la hemorragia posparto en el 81% y reduce la preeclampsia.

**Local**

Ccanto (28). Beneficios de la psicoprofilaxis obstétrica durante el trabajo de parto en las primigestas atendidas en el Hospital Regional Zacarías Correa

Valdivia de Huancavelica. La metodología fue observacional, retrospectivo, transversal y observacional, con un nivel descriptivo siguiendo el método inductivo y diseño descriptivo, desarrollado en 40 primigestas. Los resultados fueron edades de 18 a 31 años con edad promedio de 23 años, estado civil conviviente el 57.5%, soltera el 40%, con nivel de instrucción superior incompleta el 55%, con fase latente hasta 20 horas el 97.5%, fase activa hasta 6 horas el 95%, expulsivo hasta 2 horas el 40%, desgarro perineal el 7.5%, líquido amniótico claro el 87.5%. En conclusión, la psicoprofilaxis obstétrica mostró beneficios en las primigestas atendidas en el Hospital de Huancavelica.

## 2.2. Bases teóricas

### 2.2.1. Psicoprofilaxis obstétrica

#### 2.2.1.1. Historia

En épocas muy antiguas las gestantes eran ayudadas por ancianas de la tribu para su parto; las comadronas organizadas y preparadas por Hipócrates se encargaban de atender los partos (siglo XVII y XVIII). Ya en la edad media se prohíbe la compañía del varón en el momento del parto porque la Inquisición vigilaba el comportamiento de la reproducción considerando que debían sufrir los dolores tal como enfatiza la biblia; es así que en el siglo VII se inició la atención del parto con participación del médico (29).

En el siglo XIX se inicia el uso de analgésicos durante el parto, sin embargo la iglesia negaba esta práctica; en 1853 se utilizaba la mascarilla de cloroformo siendo aceptada por la población y en Rusia se realizaron experimentos de hipnosis en gestantes que aquejaban de dolor siendo aceptada en 1890 después de ser mejorado (8, 29).

En 1902 Pavlov sustenta científicamente los reflejos condicionados – hipnosis y en 1993, Dick Dear expone la

necesidad de educar a las gestantes para un parto sin temor, destacando el apoyo profesional de salud. En 1950, definen la psicoterapia de dolor del parto y en 1951 Fernand Lamazé desarrolló el método psicoprofiláctico a través de técnicas de relajación para reducir el dolor (8, 29).

#### 2.2.1.2. Bases doctrinarias

- **Escuela inglesa**

  Representado por Grantly Dick Read, en su obra parto natural, observó como las mujeres sin miedos y mociones negativas dan a luz mejor, concluyendo que el dolor es engendrado por el miedo que desencadena mecanismo de defensa en forma de tensión muscular triangulando dolor – miedo – tensión (10).

  Mediante el circulo vicioso dolor, miedo, tensión explicaba los cambios que ocurren en la mujer al inicio del parto produciéndose influencias negativas que pueden ser combatidas a través de la educación, conocimiento, comprensión de cambios en el organismo materno durante el embarazo, parto y puerperio, facilitando a la gestante para que el parto no sea un fenómeno desconocido (1, 10).

- **Escuela Soviética**

  Conocida como parto sin dolor, basados en la fisiología de Pavlov y en la teoría de los reflejos condicionados (1, 10).

- **Escuela Francesa**

  Representado por Fernand Lamaze, divulgador de la psicoprofilaxis obstétrica, un método para preparación del parto y manejo de dolor teniendo como postulado “Parto sin

dolor por el medio psicoprofiláctico en base a la educación neuromuscular.

Sobre la base de la teoría de la respuesta condicionada de Ivan Pavlov, Psicoprofilaxis se esforzó para eliminar el dolor del parto a través de la educación sobre el proceso fisiológico del parto y el nacimiento, a través de la respuesta de relajación entrenado a las contracciones uterinas, y por medio de la respiración con dibujos destinados tanto para aumentar la oxigenación e interferir con él la transmisión de señales de dolor desde el útero hasta la corteza cerebral. Lamaze quedó tan impresionado por lo que vio que después de su regreso a Francia, dedicó el resto de su vida a promover la Psicoprofilaxis Obstétrica.

- **Escuela Ecléctica**

  Representado por Leboyer, cuyo postulado fue Favorecer el momento adecuado para el encuentro padre – madre – hijo" "Parto sin dolor, parto sin violencia". La escuela ecléctica escoge lo mejor de cada escuela o teoría dirigiendo su atención hacia el recién nacido.

  Este método es conocido como "nacimiento sin violencia" o "nacimiento amable", con el interés de deshumanizar los partos. Su método se centra en el bebé, y se basa en el concepto de que el parto es un trauma para el recién nacido que se debe paliar en la medida de lo posible (1, 30).

Actualmente, la Educación Maternal constituye algo habitual entre nuestras gestantes, y está plenamente integrada dentro de nuestro sistema sanitario. El objetivo general de toda educación maternal debería ser el obtener una vivencia feliz y consciente de la maternidad/ paternidad

y del parto, como paso previo a una buena relación madre-padre-hijo (3).

#### 2.2.1.3. Definición

Es un proceso educativo para la preparación integral de la gestante, que le permite desarrollar procesos saludables que permiten experiencias felices para el binomio madre niño y su entorno saludable (1).

Así mismo, es considerado como la preparación integral teórica, física y psicoactiva durante la gestación, parto y posparto para alcanzar una jornada obstétrica en las mejores condiciones creando experiencias felices (5), por tanto, es una herramienta en la atención integral con impactos relevantes en la salud materna y neonatal cuyo propósito es reducir el dolor mediante las técnicas de relajación (30), además de fortalecer la cooperación y rol activo del padre (5).

La psicoprofilaxis promociona el parto natural con integración de la pareja y familia, donde la mujer se empodera con el embarazo, parto y puerperio disminuyendo la morbimortalidad materna y perinatal (6).

#### 2.2.1.4. Objetivos de la Psicoprofilaxis obstétrica (31)

- Proporcionar educación sobre hábitos saludables para ella.
- Brindar conocimiento acerca de los cambios físicos y psíquicos que se producen en la gestación.
- Fortalecer el trinomio madre-padre-hijo.
- Contribuir al mejoramiento de la comunicación de los padres, como soporte de las buenas relaciones familiares, realzando la importancia de la familia.

- Identificar preocupaciones que puedan surgir después del parto y proporcionar los conocimientos necesarios para actuar con responsabilidad.
- Fomentar en la gestante, la pareja y la familia una actitud positiva ante la gestación.
- Brindar las herramientas necesarias a la gestante para canalizar el estrés materno y el dolor a través de las técnicas de respiración y relajación con visualización.
- Realizar medidas de prevención para evitar molestias físicas propias de la gestación o exacerbación de molestias crónicas como las várices, las hemorroides y el estreñimiento.

#### 2.2.1.5. Beneficios de la Psicoprofilaxis obstétrica

Estudios especializados en medicina perinatal y humanización del parto desde los años 70 ofrecen grandes beneficios materno perinatales (16, 32).

- **Beneficios maternos** (16, 32)**:**
  - Reduce el tiempo de los periodos expulsivo, alumbramiento.
  - Impacto positivo sobre a motivación y vínculo afectivo prenatal.
  - Llevar una experiencia de maternidad natural y positiva, incentivando la participación activa.
  - Actitud positiva durante el parto.
  - Menor grado de ansiedad en la madre.
  - Evitar evaluaciones repetidas e innecesarias durante el trabajo de parto.
  - Adecuada respuesta a las contracciones uterinas.

- Menor uso de fármacos como oxitócicos para conducir el parto.
- Menor riesgo de complicaciones obstétricas como los desgarros.
- Menor riesgo de intervenciones innecesarias como la episiotomía, parto instrumentado y cesárea.
- Promoción del parto natural.
- Fortalece el vínculo familiar.
- Mejorar condiciones obstétricas y emocionales durante el parto.
- Reducción de la morbilidad y mortalidad materna perinatal (6).
- Mejora la calidad de vida y percepción respecto a todos los procesos.
- Menor riesgo de depresión posparto.
- Pronta recuperación posparto.
- Promueve la lactancia materna.

➢ **Beneficios perinatales (16, 32):**

- Adaptación del feto a la vida extrauterina.
- Mejora la curva del crecimiento.
- Mejora el vínculo prenatal.
- Enfoque correcto acerca la estimulación intrauterina.
- Menor porcentaje de sufrimiento fetal.
- Menor porcentaje de prematuridad.
- Menor peso al nacer.
- Mejor estado el Apgar.

➢ **Beneficios en la atención del parto** (16, 32)**:**

- Trabajo en equipo y coordinado.
- Mayor confianza con la pareja de la gestante.

- Ahorro de recursos y tiempo.
- Partos institucionalizados en buenas condiciones.

#### 2.2.1.6. Bases científicas de la psicoprofilaxis obstétrica

La fisiología del parto y la fisiología del dolor han sido motivo de múltiples investigaciones para determinar las causas del dolor en el parto, siendo necesario tres circunstancias (1, 31):

- Terminaciones nerviosas libres y específicas
- Estímulo suficiente
- Umbral de percepción del dolor adecuado

#### 2.2.1.7. Sesiones de la psicoprofilaxis obstétrica

Actualmente la psicoprofilaxis obstétrica ha incorporado nuevos conceptos con criterio y calidad que requiere el personal capacitado, para ofrecer sesiones con contenidos acorde a las condiciones de las usuarias, que contemple la personalización en cada gestante con enfoque de riesgo, ética y humanización (5, 33).

Para el desarrollo de las sesiones se debe considerar al profesional obstetra, quien está capacitado, además de contar con los instrumentos necesarios para la psicoprofilaxis obstétrica con adecuación intercultural; estas pueden ser individuales o grupales (máximo 10 personas), con desarrollo de sesiones semanales hasta un total de seis y si estas gestantes acuden al final del embrazo no debe ser inferior a tres sesiones. Las sesiones involucran temas como (1) cambios en el embarazo y signos de alarma, (2) atención prenatal y autocuidado; (3) fisiología del parto; (4) atención del parto y contacto precoz; (5) puerperio y recién nacido y (6) reconocimiento de los ambientes (31).

#### 2.2.1.8. Tipo de preparación obstétrica:

- **Preparación teórica**

  Consiste en brindar información correcta y oportuna acerca del embarazo, cuidados y hábitos necesarios para evitar resultados desfavorables disminuyendo riesgos y complicaciones obstétricas; la gestante comprende los factores de la labor obstétrica que permite su seguridad y tranquilidad que permite una evolución adecuada del embarazo (34).

- **Preparación psicoafectiva**

  Se brinda el soporte psicoemocional logrando eliminar el temor e ideas negativas para el disfrute de la llegada del bebé generando seguridad y bienestar constante. Comprende los cambios de ánimo y emociones a lo largo del embarazo reforzando el vínculo afectivo madre-niño-padre (34).

- **Preparación física**

  Desarrollo de ejercicios, entrenamiento, técnicas de respiración, relajación , masajes y posiciones antalgicas para beneficios corporales y mentales facilitando la recuperación en condiciones adecuadas (34).

### 2.2.2. Parto

El parto es la etapa de culminación del embarazo donde se expulsa al feto al exterior en un tiempo breve; empieza con las contracciones uterinas regulares y termina con el nacimiento del neonato y placenta (35, 36).

#### 2.2.2.1. Fisiología del trabajo de parto

Las últimas horas del embarazo humano se caracterizan por contracciones uterinas potentes y dolorosas que producen dilatación del cuello uterino y hacen que el feto descienda por el conducto del parto. Tanto el útero como el cérvix experimentan una preparación intensa mucho antes de que esto ocurra. En las primeras 36 a 38 semanas del embarazo normal, el miometrio se encuentra en un estado preparatorio, pero todavía sin respuesta. Al mismo tiempo, el cuello uterino comienza una primera etapa de remodelación denominada ablandamiento, aunque mantiene su integridad estructural. Después de esta quiescencia uterina prolongada, se observa una fase de transición durante la cual se suspende la falta de respuesta miometrial y el cuello uterino experimenta maduración, borramiento y pérdida de la integridad estructural (35).

Los procesos fisiológicos que regulan el parto y el inicio del trabajo de parto todavía no se han definido. Sin embargo, es claro que el comienzo del trabajo de parto representa la culminación de una serie de cambios bioquímicos en el útero y el cuello uterino. Éstos se deben a señales endocrinas y paracrinas que proceden de la madre y el feto. Sus aportaciones relativas varían entre distintas especies y son estas diferencias las que complican la dilucidación de los factores exactos que regulan el parto humano. Cuando el parto es anormal, puede haber trabajo de parto prematuro, distocia o embarazo postérmino. De éstos, el trabajo de parto prematuro es aún el principal factor que contribuye a la mortalidad y morbilidad (35).

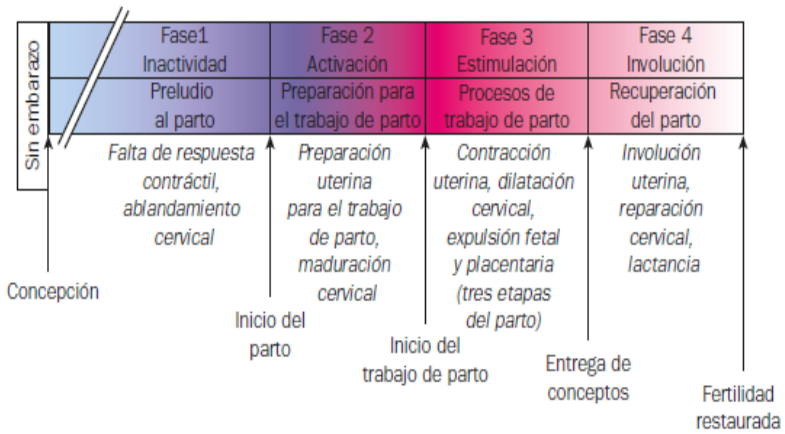
### 2.2.2.2. Fases del parto

El parto requiere múltiples transformaciones en las funciones uterina y cervicouterina; puede dividirse de manera arbitraria en cuatro fases superpuestas que corresponden a las principales transiciones fisiológicas del miometrio y el cuello uterino durante el embarazo (35, 37)

Estas fases del parto son (37):

1) preliminar
2) preparatoria
3) parto
4) recuperación.

Algo importante es que las fases del parto no deben confundirse con las etapas clínicas del trabajo de parto, es decir, la primera, segunda y tercera etapas, que comprenden la tercera fase del parto (37), como se muestra en la siguiente figura.




### 2.2.2.3. Periodos del trabajo de parto

- **Periodo de dilatación**

  La curva de dilatación promedio para el trabajo de parto en nulíparas, se basa en el análisis de datos de una serie

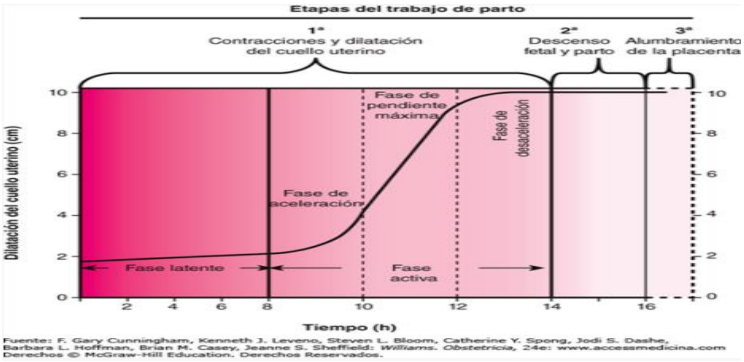
extensa y consecutiva de casos, identificándose la fase latente y fase activa.

- **Fase latente,** que consiste en dilatación de 0 a 4 cm, corresponde al momento en que la madre percibe contracciones uterinas regulares; un umbral que puede ser clínicamente útil porque define los límites de la dilatación (35).

  La fase latente prolongada aquella mayor de 20 horas en la nulípara y de 14 horas en multípara

- **Fase activa,** cuando la dilatación es ≥ 4 cm de rápida progresión comparada a la anterior en presencia de las contracciones uterinas, es representativa del umbral de trabajo de parto activo. La duración promedio de la fase activa de trabajo de parto en nulíparas es de 11.7 horas. De hecho las velocidades de dilatación del cuello uterino variaron desde un mínimo de 1.2 cm hasta 6.8 cm/hora. También se observó que las multíparas avanzaron más rápida en la fase activa de del trabajo de parto, con una velocidad normal mínima de 1.5 cm /hora (35).

  Existe gran variabilidad en la velocidad de modificación cervical por lo que se asume 1.2 cm/h como aproximado 6 horas en nulíparas y 1.5 cm/h con aproximado de 4 horas en multíparas. Cuando el cuello alcanza la dilatación de 10 cm, comienza el segundo estadio del trabajo de parto que comprende el descenso del feto por el canal del parto (35, 38).




- **Periodo Expulsivo**

  En muchas nulíparas, la orientación y encajamiento de la cabeza se logra antes de que comience el parto. Dicho esto, es posible que la cabeza no descienda más hasta el final del parto. En el patrón de descenso del trabajo de parto normal, se forma una curva hiperbólica típica cuando la estación de la cabeza fetal se traza en función de la duración del trabajo de parto. La estación describe el descenso del diámetro biparietal fetal en relación con una línea trazada entre las espinas isquiáticas de la madre.

  El descenso activo por lo general tiene lugar después de que la dilatación ha progresado durante algún tiempo. Durante la segunda etapa del trabajo de parto, la velocidad de descenso es máxima y se mantiene hasta que la parte que se presenta llegue al piso perineal. En las nulíparas, la parte que se presenta típicamente desciende lenta y constantemente.

  Sin embargo, en las multíparas, en particular las de alta paridad, el descenso puede ser rápido. La duración promedio es de casi 50 minutos para nulípara y 20 minutos para multíparas pero puede ser muy variable (35, 39).

Según Rigol (40), es cuando la dilatación se ha completado y la cabeza llega al plano perineal, la parturienta experimenta deseos de pujar en cada contracción y se abomba el perineo, por lo que sabemos que la paciente está en período expulsivo, se colocará a la paciente en posición ginecológica en una mesa de partos, donde se encuentre segura.

Aunque la protección del perineo es conveniente, no debe prolongarse exageradamente, sobre todo en primíparas tardías o cuando el perineo es alto, grueso y rígido. En estos casos se realizará su infiltración local con procaína a 1 % u otro anestésico similar y se procederá a realizar la episiotomía medio lateral derecha o izquierda. La episiotomía siempre es más ventajosa que un desgarro perineal, pero actualmente se preconiza no abusar de este proceder de no ser necesario.

Una vez expulsada la cabeza fetal, se aspiran las flemas de las fosas nasales de la orofaringe mientras se va produciendo espontáneamente el resto del mecanismo del parto.

- **Periodo de alumbramiento**

  Esta etapa comienza inmediatamente después del parto fetal e implica la separación y la expulsión de la placenta y las membranas. A medida que el recién nacido nace, el útero se contrae de manera espontánea alrededor de sus contenidos decrecientes. Normalmente, en el momento en que el recién nacido nace por completo la cavidad uterina casi se anula. El órgano consiste en una masa de músculo casi sólida, de varios centímetros de grosor, por encima

del segmento inferior más delgado. El fondo uterino ahora se encuentra justo debajo del nivel del ombligo. Esta disminución repentina en el tamaño uterino está inevitablemente acompañada de una reducción en el área del sitio de implantación placentaria. Para que la placenta se acomode a esta área reducida, se engrosa, pero debido a la elasticidad placentaria limitada, se ve obligada a doblarse. La tensión resultante tira de la capa más débil (decidua esponjosa) de ese sitio. Por tanto, la separación de la placenta sigue la desproporción creada entre el tamaño de la placenta relativamente sin cambios y el tamaño reducido del sitio de implantación. La estructura suelta de la decidua esponjosa ayuda en gran medida a la escisión de la placenta. A medida que avanza el desprendimiento, se forma un hematoma entre la placenta en separación y la decidua adyacente, que permanece unida al miometrio. El hematoma por lo general es el resultado más que la causa de la separación, porque en algunos casos el sangrado es insignificante (35).

El tiempo es 15 minutos de alumbramiento dirigido y en espontaneo es 30 minuto pasando esos tiempos se considera patológico (36).

Después de que la placenta se ha desprendido, puede ser expulsada por el aumento de la presión abdominal. La finalización de la tercera etapa también se logra comprimiendo y elevando alternativamente el fondo, mientras se ejerce una tracción mínima en el cordón umbilical. El hematoma retro placentario sigue la placenta o se encuentra dentro del saco invertido formado por las membranas. En este proceso, conocido como mecanismo de Schultz de expulsión placentaria, la sangre del sitio

placentario se vierte en el saco de la membrana y no se escapa externamente hasta después de la extrusión de la placenta. En la otra forma de extrusión placentaria, conocida como mecanismo de Duncan, la placenta se separa primero en la periferia y la sangre se acumula entre las membranas y la pared uterina y se escapa por la vagina. En esta circunstancia, la placenta desciende de lado y su superficie materna aparece primero (35).

Esquema resumen de la duración del trabajo de parto:

| Periodos del trabajo de parto | Condición de la parturienta | Tiempo |
|---|---|---|
| **Dilatación** | **Fase latente:** | |
| | Nulípara | Hasta 20 horas |
| | Multípara | Hasta 14 horas |
| | **Fase activa:** | |
| | Nulípara | 1.2 cm /h (6h) |
| | Multípara | 1.5 cm /h (4h) |
| **Expulsivo** | Nulípara | 90 a 120 min |
| | Multípara | 60 min. |
| **Alumbramiento** | Nulípara | Dilatación o descenso > 5cm/h |
| | Multípara | Dilatación o descenso > 10cm/h |

#### 2.2.2.4. Prolongación del trabajo de parto

La prolongación de los tiempos del parto se ha convertido, en un eje central de la toma de decisiones en su manejo clínico,

puesto que tradicionalmente se ha venido asociando la prolongación del mismo con un aumento de la morbimortalidad materno-fetal mediada por factores como un mayor riesgo de deshidratación, infección, rotura uterina, compromiso fetal e infección perinatal. En este sentido, la mayoría de estudios utilizan para valorar el estado neonatal instrumentos de medida indirectos como el test de Apgar o los ingresos en Unidades de Cuidados intensivos neonatales (UCIN), existiendo pocas investigaciones que utilicen instrumentos directos de medida.

**Tiempos de parto prolongados según organismo.**

| Variables | Friedman | SEGO | MPSP | Friedman | SEGO | MPSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dilatación | | | Expulsivo | | |
| Primípara con epidural | >12 h | >10 h | >18 h | >1 h | >3 h | >4h |
| Primípara sin epidural | | | | | >2 h | >3h |
| Multípara con epidural | >14 h | >10 h | >12h | 20 min | >2 h | >3h |
| Multípara sin epidural | | | | | >1 h | >2h |

Fuente: Friedman[1,2], SEGO[5], MPSP[6].

## 2.2.3. Resultados materno perinatales

### 2.2.3.1. Definición

Consecuencia o efecto de la preparación integral a la gestante para un parto sin temor sobre el binomio madre niño, acortando el tiempo durante el trabajo de parto y mejorar la oxigenación fetal (35).

### 2.2.3.2. Resultados maternos

- **Inicio del parto**
  - **Inducido**

    La inducción está indicada cuando los beneficios para la madre o el feto superan a los de la continuación del

embarazo. Las indicaciones más comunes incluyen rotura de membranas sin trabajo de parto, hipertensión gestacional, oligohidramnios, sufrimiento fetal, embarazo postérmino y diversas afecciones médicas de la madre como hipertensión crónica y diabetes (35). Los métodos para inducir o aumentar el trabajo de parto están contraindicados por la mayoría de las condiciones que imposibilitan el trabajo de parto espontáneo o el parto. Las pocas contraindicaciones de la madre están relacionadas con el tipo de incisión uterina anterior, la anatomía pélvica contraída o distorsionada, las placentas implantadas de forma anormal y las afecciones poco.

- **Espontáneo**

  Se refiere a la aparición repentina de contracciones uterinas rítmicas, periódicas capaces de generar cambios cervicales e iniciar el trabajo de parto.

- **Cesárea**

  Es el nacimiento de un feto vía de la laparotomía y después la histerotomía. Esta definición no se aplica a la extracción del feto de la cavidad abdominal en el caso de ruptura uterina o con embarazo abdominal (35).

**Indicaciones de Cesárea**

**Maternas**

- Parto previo por cesárea
- Placentación anormal
- Previa histerotomía clásica

- Tipo desconocido de cicatriz uterina
- Dehiscencia de incisión uterina
- Miomectomía previa del espesor miometrial
- Masa obstructiva del tracto genital
- Cáncer invasivo del cuello del útero
- Traquelectomía previa
- Cerclaje permanente
- Cirugía reconstructiva pélvica anterior
- Trauma perineal significativo anterior
- Deformidad pélvica
- Infección por HSV o VIH
- Enfermedad cardiaca o pulmonar
- Aneurisma cerebral o malformación arteriovenosa
- Patología que requiera cirugía intraabdominal simultánea
- Parto por cesárea perimortem.

**Materno – fetal (35)**

- Desproporción cefalopélvica
- Parto vaginal operatorio fallido
- Placenta previa o abrupción de la placenta

**Fetal (35)**

- Estatus fetal no tranquilizador
- Presentación anómala
- Macrosomía
- Anomalía congénita
- Cordón umbilical anormal por estudio Doppler
- Trombocitopenia
- Trauma neonatal en nacimiento anterior

La cesárea tiene riesgos quirúrgicos más altos para la madre en los embarazos actuales y subsiguientes, comparados con el parto espontáneo vaginal. Esto se compara contra tasas más bajas de daño perineal y trastornos del suelo de la pelvis a corto plazo. Para el recién nacido, la cesárea ofrece índices más bajos de trauma al nacer y muerte durante el parto, pero mayores tasas de dificultades respiratorias iniciales (35, 41).

- **Desgarro perineal**

  Una de las complicaciones más importantes que ocurren en el parto vaginal son los desgarros perineales , los cuales pueden producirse de manera espontánea o por la realización de una episiotomía para ampliar la apertura de la vagina y facilitar el nacimiento, o ambas . Son la segunda causa de hemorragia posparto después de la atonía uterina, se caracteriza por un sangrado vaginal activo posterior a una lesión del canal del parto que la gran mayoría requiere de sutura (42).

- **Episiotomía**

  Es una procedimiento para ampliar el canal del parto a través de sección quirúrgica de la región vulvar, tercio inferior de la vagina y tejidos perineales, con el objetivo de facilitar la expulsión fetal y preservar la integridad del suelo pelviano.

### 2.2.3.3. Resultados perinatales

- **Peso del recién nacido**

  El peso del recién nacido se clasifica en:

  - Extremadamente bajo peso: menor a 1000gr.
  - Recién nacido muy bajo peso: menor a 1500gr.
  - Recién nacido de peso moderadamente bajo: menor a 2500gr.
  - Recién nacido de peso adecuado: 2500 - 3999gr.
  - Recién nacido macrosómico: mayor 4000gr

- **Apgar**

  En la mayoría de los casos, en el momento del parto el recién nacido está sano y vigoroso, pero a veces puede ser necesario un cuidado especial. Por este motivo, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomiendan que cada nacimiento debe ser atendido al menos por una persona calificada (35); para clasificar la salud del recién nacido inmediatamente después del nacimiento tomando en cuenta las cinco características fácilmente identificables como:

  - Frecuencia cardiaca
  - Esfuerzo respiratorio
  - Tono muscular
  - Irritabilidad refleja
  - Color

    Se evalúa y se le asigna un valor de 0, 1, o 2. En la forma expandida actualmente recomendada, las intervenciones de reanimación concurrentes también se registran con el tiempo. El puntaje total, basado en

la suma de los cinco componentes, se determina en todos los neonatos en 1 y 5 minutos después del parto. En aquellos con un puntaje <*7*, el puntaje se puede calcular en intervalos de 5 minutos adicionales hasta que se asigne un puntaje de Apgar de 20 minutos, o se detengan los esfuerzos de reanimación.

**Test de APGAR**

| Acrónimo | Parámetro / Puntuación | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Apariencia | Color de piel | Cianosis o palidez | Acrocianosis, tronco rosado | Rosado o sonrosado |
| Pulso | Frecuencia cardíaca | Ausente | < 100 lpm lento | > 100 lpm rápido |
| Gesticulación | Irritabilidad Refleja | Sin respuesta | Muecas | Llanto |
| Actividad | Tono muscular | Flácido | Flexión de extremidades | Movimientos activos |
| Respiración | Esfuerzo respiratório | Ausente | Lento e irregular | Llanto vigoroso |

| | | |
|---|---|---|
| **Depresión severa** | 0 a 3 puntos | RCP neonatal avanzado más medicación, monitoreo en UCI. |
| **Depresión moderada** | 4 a 6 puntos | Puede ser necesário algunas maniobras RCP neonatal y monitoreo post recuperación. |
| **Normal** | 7 a 10 puntos | Recién nacido en buenas condiciones. |

- **Contacto piel a piel**

  El contacto piel a piel ha demostrado, según estudios a nivel mundial tener un efecto positivo para la salud del recién nacido como para la madre; su práctica está muy relacionada con el parto natural y bajo costo para los beneficios que proporciona.

  Entre los beneficios se halla la regulación de la temperatura, reduce los niveles de estrés materno y neonatal y mejora el apego y aumenta la probabilidad de una lactancia materna exclusiva de manera exitosa (43).

## 2.2.4. Índice de Robson

Robson, en el año 2001 propuso un sistema de clasificación de diez grupos sustentados en la categoría de la gestación, antecedentes obstétricos previos, el curso del trabajo de parto y la edad gestacional (44).

La clasificación de Robson es para todas las mujeres que dan a luz en un entorno específico y no solo para las que tuvieron parto por cesárea.

### 2.2.4.1. Sistema de clasificación

La Organización Mundial de la Salud, realizó una revisión sistemática de los sistemas utilizados para clasificar las cesáreas en el 2011, concluyendo que clasificación de Robson es la más adecuada para atender las necesidades locales e internacionales actuales; a su vez recomienda utilizarla como base para desarrollar un sistema de clasificación de cesáreas aplicable a nivel internacional (45).

El sistema de clasificación considera a todas la mujeres ingresadas para el parto en 10 grupos que son mutuamente excluyentes y totalmente inclusivos, ninguna puede quedar fuera de los grupos clasificados; este proceso es sencillo clínicamente adecuada permitiendo comparar las tasas de cesáreas dentro de los diez grupos y entre ellos (14).

Cada grupo de Robson acopla ciertas características de las parturientas, como paridad, cesárea previa, inicio del trabajo de parto, numero de fetos, edad gestacional en que se produce el parto, situación y presentación del feto para el análisis clínico de la gestante.

- **Diez grupos de Robson**



La población obstétrica según grupos establecidos en el sistema es:

| Grupos | Descripción de la clasificación de diez grupos |
|---|---|
| 1 | Nulíparas con un feto único en presentación cefálica, de 37 semanas o más de embarazo, que han iniciado el parto de forma espontánea. |
| 2 | Nulíparas con un feto único en presentación cefálica, de 37 semanas o más de embarazo, que han sido sometidas a inducción o cesárea antes del inicio del parto. |
| 3 | Multíparas sin cesárea previa, con un feto en presentación cefálica, de 37 o más de embarazo, que han iniciado el parto de forma espontánea. |
| 4 | Multíparas sin cesárea previa, con un feto en presentación cefálica, de 37 semanas o más de embarazo, que han sido sometidas a inducción o cesárea antes del inicio del parto. |
| 5 | Multíparas con al menos una cesárea previa, con un feto único en presentación cefálica, de 37 semanas o más de embarazo. |
| 6 | Nulíparas con un feto único en presentación podálica. |
| 7 | Multíparas con un feto único en presentación podálica, incluyendo aquellas con cesárea previa. |
| 8 | Todas las mujeres con embarazo múltiple, incluyendo aquellas con cesárea previa. |
| 9 | Todas las mujeres con feto único en posición transversa u oblicua, incluyendo aquellas con cesárea previa. |
| 10 | Todas las mujeres con un feto único en presentación cefálica de menos de 37 semanas de embarazo, incluyendo aquellas con cesárea previa. |

## 2.3. Definición de términos

- **Resultado materno perinatal,** consecuencia del embarazo en el binomio madre niño, pudiendo ser aspectos normales como patológicos.
- **Paridad,** número de partos sean con nacimientos vivos u óbitos.
- **Parto,** proceso fisiológico en la que culmina el embarazo.
- **Sesión de psicoprofilaxis obstétrica,** desarrollo del contenido temático que implica diagnóstico obstétrico y tratamiento de PPO individualizado de acuerdo a condiciones de cada gestante.
- **Test de Apgar,** evaluación al neonato considerando cinco parámetros (frecuencia cardiaca, tonicidad, color de la piel, llanto, esfuerzo respiratorio) que se realiza al primer y quinto minuto después del nacimiento (36).
- **Gestante preparada,** gestante que recibió seis sesiones de psicoprofilaxis obstétrica.

## 2.4. Hipótesis

### 2.4.1. Hipótesis general

$H_0$ = No existen diferencias en los resultados materno perinatales e índice de cesáreas en puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019.

$H_1$ = Existen diferencias en los resultados materno perinatales e índice de cesáreas en puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019.

## 2.5. Variables

**Variable 1**: Resultados materno perinatales

**Variable 2**: Índice de cesárea

**Variable 3**: Psicoprofilaxis obstétrica

## 2.6. Operacionalización de variables

| VARIABLE 1 | DEFINICION CONCEPTUAL | DEFINICION OPERACIONAL | DIMENSIONES | SUB DIMENSIÓN | INDICADOR | ESCALA | TIPO DE VARIABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados materno perinatales | Consecuencia de un evento sobre la salud materna perinatal. | Es el registro de las consecuencias materno perinatales en gestantes que recibieron psicoprofilaxis obstétrica. | Resultados materno perinatales | Características maternas | Estado civil | Casada ( )<br>Conviviente ( )<br>Soltera ( ) | Nominal |
| | | | | | Nivel de instrucción | Primaria ( )<br>Secundaria ( )<br>Superior No universitario ( )<br>Superior Universitario ( )<br>Sin estudios | Ordinal |
| | | | | | Atención prenatal | < 4 APN ( )<br>4 a 6 APN ( )<br>> 6 APN ( ) | Ordinal |
| | | | | | Paridad | Primípara ( )<br>Multípara ( )<br>Gran multípara ( ) | Ordinal |
| | | | | | Espacio intergenésico | Corto ( )<br>Normal ( )<br>Largo ( ) | Ordinal |
| | | | | | Cesárea previa | Si ( )<br>No ( ) | |
| | | | | | Edad gestacional al momento de parto | < 37 semanas ( )<br>37 a 41 semanas ( )<br>> 41 semanas ( ) | Ordinal |
| | | | | Resultados materno perinatales | Resultados maternos | Inicio del parto (espontáneo, inducido, cesárea programada) | Nominal |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dilatación | Normal<br>Prolongada |
| | | | | | | Expulsivo prolongado | Si ( ) No ( ) |
| | | | | | | Complicación | Preeclampsia ( )<br>Macrosomía fetal ( )<br>Otros… |
| | | | | | Resultado perinatal | Situación transversa<br>Presentación (cefálica/podálica) | Nominal |
| | | | | | | Número de fetos (simple/doble) | Nominal |
| | | | | | | Peso del neonato ( ) | Ordinal |
| | | | | | | Apgar al minuto ( ) | Ordinal |
| | | | | | | Contacto piel a piel ( )<br>Tipo de parto | Nominal |
| **VARIABLE 2** | **DEFINICION CONCEPTUAL** | **DEFINICION OPERACIONAL** | **DIMENSIONES** | **SUB DIMENSIÓN** | **INDICADOR** | **ESCALA** | **TIPO DE VARIABLE** |
| Índice de cesáreas | Sistema para el seguimiento y comparación de tasas de cesáreas. | Registro de la cesárea según la clasificación de Robson | Cesáreas | Aplicable en todas las mujeres ingresadas para el parto, debiendo pertenecer a un solo grupo. | Clasificación de Robson | Grupo de I<br>Grupo de II<br>Grupo III<br>Grupo IV<br>Grupo V<br>Grupo VI<br>Grupo VII<br>Grupo VIII<br>Grupo IX<br>Grupo X | Nominal |

| VARIABLE 3 | DEFINICION CONCEPTUAL | DEFINICION OPERACIONAL | DIMENSIONES | SUB DIMENSIÓN | INDICADOR | ESCALA | TIPO DE VARIABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psicoprofilaxis obstétrica | Es un proceso educativo para la preparación integral de la gestante que le permite desarrollar hábitos y comportamientos saludables frente al embarazo, parto y puerperio. | Registro de asistencia a las sesiones de la PPO. | Psicoprofilaxis obstétrica | PPO durante el embarazo | Asistió a sesiones | **Si ( )**<br>**No ( )** | Nominal |

# CAPÍTULO III

# METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

## 3.1. Ámbito temporal y espacial

### 3.1.1. Ámbito temporal

Esta referido al espacio de tiempo que delimita el estudio; tal es así que la investigación se desarrolló en el año 2019, de enero a diciembre, tomando en cuenta los registros generados cuando algunas gestantes acudían de forma presencial a las sesiones de psicoprofilaxis obstétrica.

### 3.1.2. Ámbito espacial

El estudio se desarrolló en el Hospital Departamental de Huancavelica, órgano descentralizado con dependencia de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, con capacidad resolutiva II-2, con atención ambulatoria y hospitalaria especializada.

Entre los servicios ofertados se hallan el programa de psicoprofilaxis obstétrica.

## 3.2. Tipo de investigación

El estudio corresponde a una investigación básica cuya finalidad es la búsqueda de nuevos conocimientos y el progreso científico (46, 47); seccionales o transversales porque se realiza en una sola ocasión; analítico porque mide las relaciones de influencia entre las variables para conocer el grado de

dependencia entre estos. Retrospectivo, porque se recurrió a fuentes secundarias (48).

## 3.3. Nivel de investigación

El estudio corresponde al nivel relacional, porque se recolectan información en varias muestras sobre un mismo fenómeno para comparar los datos recogidos (49, 50), en este caso comparación de la variable en dos grupos.

## 3.4. Métodos de investigación

Los métodos son procedimientos lógicos a través del cual utilizan el pensamiento en sus diversas funciones como el análisis y la síntesis, aplicados fueron unos de forma general y otro método específico, siendo estos:

### 3.4.1. Método general

Se utilizó el método inductivo porque se obtuvo conclusiones generales a partir de premisas particulares; en la que se utilizó cuatro pasos esenciales empezando de la observación de los hechos, la clasificación y estudio de los hechos y la derivación inductiva que parte de los hechos y permitió llegar a una generalización (46).

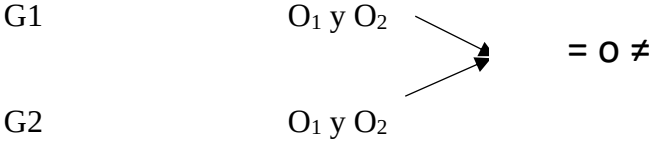
### 3.4.2. Método específico

El método analítico, porque se distinguen los elementos de un fenómeno, se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos (51); consiste en extraer una parte de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas para evaluar la relación que existe entre los elementos que conforman el objeto de estudio como un todo (47).

## 3.5. Diseño de investigación

El diseño es una estrategia metodológica para el desarrollo de un estudio (48), este orienta y guía al investigador en un conjunto de pautas a seguir siendo de

carácter flexible (51). El diseño empleado es descriptivo comparativo, cuyo esquema es:




Donde:

$G_1$ = puérperas con psicoprofilaxis obstétrica

$G_2$ = puérperas sin psicoprofilaxis obstétrica

$O_1$ = resultados maternos perinatales

$O_2$ = índice de cesárea

## 3.6. Población, muestra y muestreo

### 3.6.1. Población

La población es el conjunto de elementos que pertenece al ámbito espacial delimitado en la investigación, para el estudio estuvo constituida por 36 puérperas que durante su gestación participaron a las sesiones de psicoprofilaxis obstétrica en el Hospital Departamental de Huancavelica. Así como por puérperas que durante su embarazo no asistieron a la psicoprofilaxis obstétrica; siendo 36 puérperas preparadas en PPO y 215 puérperas sin sesiones.

### 3.6.2. Muestra

Se realizó el estudio en puérperas preparadas en psicoprofilaxis obstétrica atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, así como por puérperas que tienen las mismas edades en el mismo contexto pero que no asistieron a las sesiones de psicoprofilaxis del mismo establecimiento de salud, clasificando en dos etapas.

Para los dos grupos se tomó en cuenta los siguientes parámetros:

- Edad materna mayores de 15 años
- Residencia en el cercado de la ciudad.

1° etapa: Se identificó la totalidad de puérperas preparadas en psicoprofilaxis obstétrica (47) y la totalidad de puérperas sin sesiones de psicoprofilaxis 215, ambas con los mismos parámetros; dado que las cantidades no eran homogéneas pues había muchas puérperas sin sesiones se establece la siguiente proporción:

| **Edad** | Con psicoprofilaxis | Sin Psicoprofilaxis |
|---|---|---|
| 15 a 19 años | 4 | 4 |
| 20 a 34 | 28 | 28 |
| ≥ 35 años | 4 | 4 |
| Total | 36 | 36 |

### 3.6.3. Muestreo

El muestreo aplicado es no probabilístico de tipo intencional, el muestreo está basado en la selección de los casos que serán más convenientes para el estudio.

## 3.7. Técnicas e instrumentos para recolección de datos

### 3.7.1. Técnica

La técnica constituyen los procedimientos concretos que el investigador aplica para recolectar los datos, aplicar un conjunto de medios e instrumentos a través de los cuales se efectúa el método (51); por tanto, en el estudio se aplicó la técnica del análisis

documental basado en la revisión de las historias clínicas de las puérperas del Hospital Departamental de Huancavelica

### 3.7.2. Instrumento

Se utilizó la ficha de registro con validación cualitativa a través del juicio de expertos; está estructurado en dos partes a) resultados materno perinatales y b) índice de cesáreas acorde a la naturaleza del estudio.

## 3.8. Técnica y procesamiento de análisis de datos

- **Primero**: Se solicitó la autorización al Hospital Departamental de Huancavelica para la ejecución del estudio.
- **Segundo**: Se coordinó con las responsables del manejo de historias clínicas y registros del servicio de psicoprofilaxis obstétrica.
- **Tercero**: Se identificó las historias clínicas de las puérperas de acuerdo a los criterios de selección.
- **Cuarto**: Se procedió con la recolección de los datos según la ficha de registro.
- **Quinto:** Se elaboró una base de datos a través del Microsoft Excel.

Se ordenaron y codificaron las fichas de registro recolectadas por la asistente de investigación.

Se procedió a elaborar una base de datos en el spss versión 24, con el que se realizó un análisis de acuerdo a la naturaleza del estudio.

Los datos se presentan en tablas de frecuencias acorde a las variables, así mismo se aplicó la estadística inferencial a través de pruebas no paramétricas.

# CAPÍTULO IV

# PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

## 4.1. Análisis de información

Tabla 1. Características sociodemográficas de las puérperas post cesárea con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019.

| Características sociodemográficas | Con Psicoprofilaxis obstétrica | | Sin Psicoprofilaxis obstétrica | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frecuencia (n = 36) | Porcentaje (100.0%) | Frecuencia (n = 36) | Porcentaje (100.0%) | Frecuencia (n = 72) | Porcentaje (100.0%) |
| **Estado civil** | | | | | | |
| Conviviente | 27 | 75.0% | 30 | 83.3% | 57 | 79.1% |
| Soltera | 7 | 19.4% | 5 | 13.9% | 12 | 16.7% |
| Casada | 2 | 5.6% | 1 | 2.8% | 3 | 4.2% |
| **Grado de instrucción** | | | | | | |
| Primaria | 1 | 2.8% | 3 | 8.3% | 4 | 5.6% |
| Secundaria | 9 | 25.0% | 18 | 50.0% | 27 | 37.5% |
| Superior No universitario | 9 | 25.0% | 11 | 30.6% | 20 | 27.8% |
| Superior Universitario | 17 | 47.2% | 4 | 11.1% | 21 | 29.1% |
| **Atención prenatal** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor a 4 | 1 | 2.8% | 3 | 8.3% | 4 | 5.6% |
| 4 a 6 APN | 4 | 11.1% | 12 | 33.3% | 16 | 22.2% |
| > 6 APN | 31 | 86.1% | 21 | 58.4% | 52 | 72.2% |
| **Paridad** | | | | | | |
| Primípara | 22 | 61.1% | 16 | 44.4% | 38 | 52.8% |
| Multípara | 14 | 38.9% | 20 | 55.6% | 34 | 47.2% |
| **Espacio intergenésico** | | | | | | |
| Corto | 3 | 8.3% | 6 | 16.7% | 9 | 12.5% |
| Normal | 3 | 8.3% | 6 | 16.7% | 9 | 12.5% |
| Largo | 6 | 16.7% | 9 | 25.0% | 15 | 20.8% |
| No aplica | 24 | 66.7% | 15 | 41.6% | 39 | 54.2% |
| **Cesárea previa** | | | | | | |
| Si | 3 | 8.3% | 6 | 16.7% | 9 | 12.5% |
| No | 33 | 91.6% | 30 | 83.3% | 66 | 91.6% |
| **Parto** | | | | | | |
| Pre término | 1 | 2.8% | 1 | 2.8% | 2 | 2.8% |
| A término | 33 | 91.6% | 34 | 94.4% | 67 | 93.0% |
| Postérmino | 2 | 5.6% | 1 | 2.8% | 3 | 4.2% |

Fuente: Ficha de registro aplicado en las historias clínicas de puérperas del Hospital Departamental de Huancavelica, 2019.

En la presente tabla, se aprecia las características sociodemográficas de las puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica; entre ellas el estado civil de convivencia el 79.1% (57) donde el 83.3% (30) corresponden a puérperas sin psicoprofilaxis obstétrica frente al 75.0% (27) con psicoprofilaxis obstétrica.

El grado de instrucción más frecuente fue nivel secundaria el 37.5% (27) donde el 50.0% (18) corresponden a sin psicoprofilaxis obstétrica frente al 25.0% (9) con psicoprofilaxis obstétrica; asimismo hallamos el nivel superior universitario con 29.1% (21), donde en puérperas con psicoprofilaxis fue el 47.2% (17) frente al 11.1% (4) de puérperas sin psicoprofilaxis obstétrica.

La atención prenatal fue mayor a 6 atenciones con 72.2% (52), con psicoprofilaxis obstétrica el 86.1%(31) frente a sin psicoprofilaxis obstétrica el 58.4% (21).

Respecto a la paridad fueron primípara el 58.3% (42) donde con psicoprofilaxis fue el 61.1% (22) frente al 44.4% (sin psicoprofilaxis obstétrica y en el caso de la multiparidad se halló el 41.7% (30), donde con psicoprofilaxis obstétrica fue el 38.9% (14) frente al 55.6% (20) de sin psicoprofilaxis obstétrica.

El espacio intergenésico fue largo el 20.8% (15), donde con psicoprofilaxis obstétrica fue e1 6.7% (6)frente al 25.0% (9); corto el 12.5% (9) donde corresponde con psicoprofilaxis obstétrica el 8.3% (3) frente al 16.7% (6) sin psicoprofilaxis obstétrica; no aplica en el 54.2% (39) donde con psicoprofilaxis obstétrica fue el 66.7% (24) frente al 41.6% (15).

La cesárea precia, fue solo el 8.3% (3) en el grupo de las que hicieron la psicoprofilaxis obstétrica mientras que en el otro grupo fue del 16.7% (6).

El término del parto en el grupo con psicoprofilaxis obstétrica fue pretérmino el 2.8% (1), seguido a término en el 91.6% (33) y post término el 5.6% (2) mientras que en el grupo sin psicoprofilaxis obstétrica fue pretérmino el 2.8% (1), a término 94.4% (34) y postérmino el 2.8% (1); es decir sin diferencias en ambos grupos.

**Tabla 2.** Resultados materno perinatales en puérperas post cesárea con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019.

| Resultado Materno Perinatal | CON PPO | | SIN PPO | | Total | | $X^2$ | P - valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frecuencia (n = 36) | Porcentaje (100.0%) | Frecuencia (n = 36) | Porcentaje (100.0%) | Frecuencia (n = 72) | Porcentaje (100.0%) | | |
| **Inicio del trabajo de parto** | | | | | | | | |
| Espontáneo | 25 | 69.4% | 14 | 38.9% | 39 | 54.2% | | |
| Acentuado | 0 | 0.0% | 3 | 8.3% | 3 | 4.2% | | |
| Inducido | 1 | 2.8% | 13 | 36.1% | 14 | 19.4% | 3.432 | 0.041 |
| Cesárea programada | 10 | 27.8% | 6 | 16.7% | 16 | 22.2% | | |
| **Duración del periodo de dilatación** | | | | | | | | |
| Normal | 12 | 33.3% | 8 | 22.2% | 20 | 27.8% | | |
| Estacionaria e irregular | 14 | 38.9% | 25 | 61.1% | 39 | 54.1% | 54.21 | 0.45 |
| No aplica | 10 | 27.8% | 3 | 18.3% | 13 | 18.1% | | |
| **Apgar al minuto** | | | | | | | | |
| 0 a 3 | 0 | 0.0% | 1 | 2.8% | 1 | 1.4% | …… | …… |
| 4 a 6 | 0 | 0.0% | 1 | 2.8% | 1 | 1.4% | | … |
| 7 a más | 36 | 100.0 % | 34 | 94.4% | 70 | 97.2% | | |
| **Contacto precoz piel a piel** | | | | | | | | |
| Si | 30 | 83.3% | 25 | 69.4% | 55 | 76.4% | 12.2 | 0.06 |
| No | 6 | 16.7% | 11 | 30.6% | 17 | 23.6% | | |

Fuente: Ficha de registro aplicado en las historias clínicas de puérperas del Hospital Departamental de Huancavelica, 2019.

En la presente tabla, se observa los resultados materno perinatales post cesareadas con y sin psicoprofilaxis obstétrica hallándose un inicio de trabajo de parto espontáneo en el 69.4% (25) de las que asistieron a psicoprofilaxis obstétrica frente al 38.9% (14) en cesareadas sin psicoprofilaxis obstétrica, recibieron acentuación en el grupo sin psicoprofilaxis obstétrica el 8.3% (3) e inducido en el 36.1% (13); encontrándose

diferencias significativas en el inicio del trabajo de parto con un p-valor de 0.04 inferior a 0.05.

La duración del periodo de dilatación en las que participaron de psicoprofilaxis obstétrica fue normal en el 33.3% (12), estacionaria e irregular en el 38.9% (14) frente a las que no participaron de psicoprofilaxis obstétrica donde la duración fue normal el 22.2% (8), estacionaria e irregular el 61.1% (25). No se encontró diferencias significativas en ambos grupos (p-valor > 0.05).

El Apgar al minuto fue al 100.0% normal en las que asistieron a psicoprofilaxis obstétrica mientras que en el grupo de los que no asistieron a psicoprofilaxis tuvieron el 5.6% (2) con Apgar menor a 7. No se encontró diferencias significativas en ambos grupos (p-valor > 0.05).

Respecto al contacto precoz piel a piel fue el 55.6% (20) en el grupo con psicoprofilaxis obstétrica frente al 69.4% (25) sin psicoprofilaxis obstétrica, no hubo diferencias significativas en ambos grupos (p-valor > 0.05).

**Tabla 3**. Grupo de cesárea frecuentes en las puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019.

| Índice de cesárea | | CON PPO | | SIN PPO | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Frecuencia (n=36) | Porcentaje (100.0%) | Frecuencia (n=36) | Porcentaje (100.0%) | Frecuencia (n=72) | Porcentaje (100.0%) |
| Grupo I | Nulíparas con embarazo único con presentación cefálica ≥ 37 semanas de gestación y en trabajo de parto espontáneo | 11 | 30.6% | 10 | 27.8% | 21 | 29.2% |
| Grupo II | Nulíparas con embarazo único, con presentación cefálica ≥ 37 semanas de gestación en las que se han inducido el parto o se ha realizado una cesárea programada | 9 | 25.0% | 6 | 16.7% | 15 | 20.8% |
| Grupo III | Multíparas sin una cesárea previa, con embarazo único con presentación cefálica ≥ 37 semanas de gestación en trabajo de parto espontáneo. | 7 | 19.4% | 4 | 11.1% | 11 | 15.3% |
| Grupo IV | Multíparas sin una cesárea previa, con embarazo único con presentación cefálica de 37 a más semanas de gestación en las que inducido el parto o bien se ha realizado una cesárea programada | 1 | 2.8% | 3 | 8.3% | 4 | 5.6% |
| Grupo V | Todas las multíparas con al menos una cesárea previa, con un embarazo único de presentación cefálica de ≥ 37 ss. | 4 | 11.1% | 4 | 11.1% | 8 | 11.1% |
| Grupo VI | Todas nulíparas con embarazo único y presentación podálica. | 1 | 2.8% | 3 | 8.3% | 4 | 5.6% |
| Grupo VII | Todas las multíparas con embarazo único y presentación podálica, incluidas las que han tenido una o varias cesáreas previas | 1 | 2.8% | 2 | 5.6% | 3 | 4.2% |
| Grupo VIII | Todas las multíparas con embarazos múltiples, incluidas en las que han tenido una o varias cesáreas | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Grupo IX | Todas las mujeres con feto en situación transversa u oblicua, incluidas las que han tenido una o varias cesáreas previas. | 1 | 2.8% | 3 | 8.3% | 4 | 5.6% |
| Grupo X | Todas las mujeres con embarazo único con presentación cefálica, < a 37 semanas a más de gestación, incluidas las que han tenido una o varias cesáreas previas | 1 | 2.8% | 1 | 2.8% | 2 | 2.8% |
| | **Total** | 36 | 100.0% | 36 | 100.0% | 72 | 100.0% |

En la presente tabla se observa el grupo frecuente de cesárea en las puérperas en las que asistieron a psicoprofilaxis obstétrica frente a las que no asistieron a psicoprofilaxis obstétrica siendo en el grupo I el 30.6% (11) frente al 27.8% (10); seguido del Grupo II con 25.0% frente al 16.7% respectivamente, notándose nuliparidad con embarazos únicos de presentación cefálica, a término con partos espontáneos (grupo I) o cesáreas programadas (Grupo II) y el grupo V, es decir multíparas con alguna cesárea previa con embarazos únicos, a término y cefálicos proporcionales para ambos grupos con el 11.1%.

## 4.2. Prueba de hipótesis

Se estableció la diferencia de los resultados materno perinatales en dos grupos con y sin psicoprofilaxis obstétrica a través de la prueba chi cuadrado de homogeneidad con su p-valor. En este caso se contó con dos variables independientes para establecer igualdad o diferencias de grupos que han sido apareados según la edad, tras un profundo conocimiento del tema en cuestión y una rigurosa búsqueda bibliográfica (52); la finalidad de la prueba es comparar las variables en grupos.

Las hipótesis planteada fue probar la diferencia de los resultados materno perinatales en puérperas post cesareadas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, con un I.C del 95%; se aplicó el chi cuadrado de homogeneidad, cuyo valor obtenido en el caso del inicio del parto fue 0.01, por lo que es la única variable diferente en ambos grupos; en el caso de la duración del periodo expulsivo entre otros resultados e índice de Robson no hubo diferencia significativa.

## 4.3. Discusión de resultados

Las características sociodemográficas de las puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica como grado de instrucción secundaria fue 50.0% en las puérperas sin psicoprofilaxis obstétrica frente al nivel superior con 47.2% en el grupo con psicoprofilaxis obstétrica, al respecto estudios reportan mayor frecuencia en el nivel secundario para ambos grupos; sin embargo, se podría entender de estos resultados que las mujeres con niveles educativos mayores valoran el impacto y beneficio que tiene la psicoprofilaxis obstétrica.

La atención prenatal mayor a 6 atenciones en el grupo con psicoprofilaxis obstétricas fue del 86.1% frente al 58.4% sin psicoprofilaxis obstétrica y el estado civil conviviente en el 75.0% frente al 83.3% sin diferencias estadísticas; similar a lo hallado en un Hospital de Lima por Ocrospoma (23) donde la convivencia fue del 77% frente al 70% y los controles prenatales mayor a 6 al 100.0% frente al 47%, sin embargo, diferente a lo hallado en un Hospital de

Cusco por Coaquira (22) donde la convivencia era propia de las gestantes con PPO y soltera de las puérperas sin PPO sin diferencia estadística. El estado civil al parecer no sería un criterio de asistir o no a la psicoprofilaxis obstétrica puesto que después de la reapertura del programa de psicoprofilaxis obstétrica en el Hospital Departamental la participación es escasa.

La paridad fueron primíparas en el grupo con psicoprofilaxis obstétricas fue del 61.1% frente al 44.4% sin psicoprofilaxis obstétrica; además del espacio intergenésico en el caso de las segundíparas y multíparas fue largo en el grupo con psicoprofilaxis obstétrica representado por 16.7% frente al 25.0% sin psicoprofilaxis obstétrica, resultados similares a lo hallado en un Hospital materno cubano donde son las primigestas que participan de psicoprofilaxis son mayores comparado que las multigestas (18), al respecto el mayor temor de las primigestas es al parto como un proceso aun no conocido que eleva el interés por participar en la psicoprofilaxis; sin embargo los beneficios es para todas las gestantes indistintamente de la paridad (36).

La cesárea previa en el grupo con psicoprofilaxis obstétrica fue del 8.3% mientras que en el grupo que no hizo la psicoprofilaxis obstétrica fue del 16.7% y respecto al tiempo de gestación no hubo diferencias en ambos grupos siendo la mayoría embarazos a término con el 91.6% frente al 94.4%. Al respecto, mucho coinciden que una cesárea previa no es indicación absoluta de cesárea pudiendo ser manejada de forma natural (53-56).

Los resultados materno perinatales en el grupo de puérperas con psicoprofilaxis obstétrica fue espontáneo el 69.4%, con cesárea programada el 27.8%, sin casos de inducción mientras que en el grupo sin psicoprofilaxis obstétrica fueron sólo el 54.2% inicio espontáneo, inducido el 19.4%, acentuación el 4.2% y cesárea programada el 22.2%; respecto a la duración del periodo de dilatación fue estacionaria e irregular en el grupo sin psicoprofilaxis obstétrica representada con el 50.0%; resultados que concuerdan con un estudio en Ecuador por Regalado (21), donde el inicio del parto fueron espontáneos y con menor duración terminando a diferencia del estudio en partos vaginales pero que

requirió conducción del parto el 6.5% además de una colaboración activa y positiva de las parturientas; lo mismo encontró Ocrospoma (23) en un Hospital de Lima donde el inicio del trabajo de parto fue espontáneo el 97% frente al 43%, partos acentuados 0% con PPO frente al 33% sin PPO y el estudio desarrollado en el Centro Materno Infantil Cesar López Silva en Lima (25) encontró que las gestantes preparadas tuvieron menor duración de los periodos del parto enfatizando que el periodo de dilatación las contracciones fueron rítmicas con actitud positiva de la parturienta, al respecto estudios como Zapata (18) afirman que las primigestas preparadas en psicoprofilaxis obstétrica perdieron el temor y pudieron desencadenar trabajos de partos naturales sin necesidad de llegar a cesáreas, además que las parturientas preparadas en psicoprofilaxis obstétrica no requirieron de inducciones ni analgésicos mejorando la dinámica uterina y por ende el índice de cesáreas (19), concordando con enfoque teóricos que afirman que una de las consecuencias de la preparación en psicoprofilaxis obstétrica es promover los partos fisiológicos.

No hubo diferencias en el Apgar al minuto al nacimiento en ambos grupos en la mayoría fueron normales, y el contacto piel a piel fue mayor en el grupo con psicoprofilaxis obstétrica representado por 83.3% frente al 69.4% sin psicoprofilaxis obstétrica; resultados similares a lo encontrado en un Hospital Materno de Lima (23), donde el Apgar fue normal al 100% en las gestantes preparadas con PPO frente al 73% sin PPO y el contacto piel a piel fue del 100.0% frente al 67% respectivamente, y similar se reporta en un Centro Materno de Lima (25), donde el Apgar fue mejor en las gestantes preparadas comparadas a las que no recibieron PPO, también se acoge los resultados de Osorio (26) cuyo estudio en el Hospital Sergio Bernales – Lima reporta contacto precoz de 93.3% en las que tuvieron PPO frente al 84.4% sin PPO. Estos resultados enfatizan el beneficio de la psicoprofilaxis obstétrica en la promoción del contacto precoz, que permite mejorar la oxigenación (35) con grandes posibilidades de una lactancia materna exitosa (43).

El grupo de cesáreas frecuentes en puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica son proporcionales en el Grupo I con el 30.6% y 27.8%, respectivamente;

seguido del grupo II con el 25.0% y 16.7%, Grupo III 19.4% frente al 11.1%; es decir las cesáreas fueron en su mayoría en embarazos únicos con presentación cefálica ≥ 37 semanas de gestación con inicios espontáneos en algunos casos con cesárea previa; estos resultados difieren de Elizalde (20) en México donde las cesáreas se debían a grupos con posiciones transversas, podálicas o más de una cesárea previa justificando la cesárea; sin embargo, los estudios de Déctor (19) y Daza (24) en Cusco y Lima, respectivamente, confirma que la psicoprofilaxis obstétrica favoreció el estado emocional reduciendo las cesáreas innecesarias más no concuerda con resultados hallados por García (27) quien encontró en Loreto, que de las 58 preparadas 21 terminaron en cesáreas desconociendo las indicaciones; por tanto, posiblemente las sesiones de psicoprofilaxis requieren mayor practicidad para que las parturientas puedan afianzar su confianza y desarrollar un parto natural; además que ciertas características de las parturientas como paridad, cesaría previa, inicio de parto, numero de fetos y presentación cefálica permite hacer un análisis grupal para justificación de las cesáreas (14).

Finalmente, los resultados enfatizan que las cesáreas son innecesarias toda vez que tienen un inicio espontáneo, y que las cesáreas previas posiblemente requieran de chances vaginales; está claro, que la educación materna es una herramienta no difundida en toda su amplitud porque las bondades como el de reducir tiempos de las fases del trabajo de parto, reducir el dolor, contacto precoz, entre otros aspectos psicoemocionales coadyuva a una conducción positiva del parto (8, 29) que permiten experiencias felices para el binomio madre – niño (1) favoreciendo el rol del padre (5).

# CONCLUSIONES

1. Las características sociodemográficas que difieren en las puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica fueron nivel de instrucción superior frente al secundario, primiparidad frente a multiparidad, cesárea previa el doble en puérperas sin preparación frente a las preparadas y las características similares fueron estado civil convivientes, atención prenatal mayor a 6 y cesárea previa.
2. Existe diferencia significativa en el resultado materno perinatal, inicio del trabajo de parto espontáneo en puérperas con psicoprofilaxis obstétrica frente a inducciones en el caso del grupo sin psicoprofilaxis obstétrica; respecto a la duración del periodo de dilatación, Apgar del neonato y contacto precoz no hubo diferencias significativas en ambos grupos.
3. El grupo de cesáreas según la escala de Robson en puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica fueron nulíparas, con inicio de parto espontáneo, mayor o igual a 37 semanas en algunos casos con cesárea previa.

# RECOMENDACIONES

- Al Jefe del servicio de gineco obstetricia:

  Implementar guías de procedimientos de cesáreas con herramientas como la clasificación Robson, para identificar grupos que generan mayor impacto en el aumento de estas.

  Promover auditorias clínicas que controlen la frecuencia de cesáreas innecesarias.

- Al personal de Centro obstétrico:

  Contemplar en el informe obstétrico datos que permitan conocer con mayor claridad los motivos que conducen a una indicación de cesárea, así enriquecer estudios de mayor complejidad y profundidad.

  Promover la psicoprofilaxis obstétrica de emergencia en las pacientes que no recibieron las sesiones a fin de reforzar conocimientos y promover contacto precoz, lactancia materna exclusiva, entre otros beneficios que esta tiene.

  Realizar el seguimiento de las gestantes que acuden a las sesiones de psicoprofilaxis a fin de garantizar que estén preparadas.

  Promocionar y sensibilizar a la población gestante la importancia de las sesiones de psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal

- A la comunidad científica:

  Desarrollar estudios de mayor complejidad a fin de evaluar los beneficios de psicoprofilaxis obstétrica y el seguimiento en las que participan del programa.

  Impulsar estudios de mayor complejidad que demuestren el impacto que tiene la psicoprofilaxis obstétrica.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


1. Organización Mundial de la Salud - OMS. Guia Tecnica de Psicoprofilaxis Obstetrica y Estimulacion Prenatal. 2012.
2. İsbir GG, Inci F, Önal H, Yıldız PD. The effects of antenatal education on fear of childbirth, maternal self-efficacy and post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms following childbirth: an experimental study. Applied Nursing Research. 2016;32:227-32.
3. O'Kelly SM, Moore ZEH. Antenatal maternal education for improving postnatal perineal healing for women who have birthed in a hospital setting. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017(12).
4. Ye J, Betrán AP, Guerrero Vela M, Souza JP, Zhang J. Searching for the optimal rate of medically necessary cesarean delivery. Birth. 2014;41(3):237-44.
5. Morales Alvarado S, Guibovich Mesinas A, Yábar Peña M. Psicoprofilaxis Obstétrica: actualización, definiciones y conceptos. Horizonte Médico. 2014;14:53-7.
6. Macías KBZ, Vasconez MPT, Martínez ATB, Mera YYP. Psicoprofilaxis obstétrica y sus beneficios para la gestante. RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento. 2018;2(3):242-59.
7. Soto C, Teuber H, Cabrera C, Marín M, Cabrera J, Da Costa M, et al. Educación prenatal y su relación con el tipo de parto: una vía hacia el parto natural. Revista chilena de obstetricia y ginecología. 2006;71(2):98-103.
8. Espinoza C. Psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal. Chimbote-México: Universidad Católica de los Ángeles. 2012;20.
9. Rodriguez Neira CA. Beneficios materno-perinatales de la psicoprofilaxis obstétrica en las gestantes de los consultorios de Medicina Familiar Comunitaria del Centro de Salud Pascuales de febrero del 2017 a junio del 2018. 2018.
10. Morales Alvarado S, Guibovich Mesinas A, Yábar Peña M. Psicoprofilaxis Obstétrica: Actualización, definiciones y conceptos. Horizonte Médico (Lima). 2014;14(4):53-7.
11. Vogel JP, Betrán AP, Vindevoghel N, Souza JP, Torloni MR, Zhang J, et al. Use of the Robson classification to assess caesarean section trends in 21 countries: a

secondary analysis of two WHO multicountry surveys. The Lancet Global Health. 2015;3(5):e260-e70.

12. Aguilar Redondo R, Manrique Fuentes G, Denaroso A, Mauro L, Delgado Martínez L, González Acosta V, et al. Uso de la clasificación de Robson en un Hospital Comarcal de España para reducir la tasa de cesáreas. Revista chilena de obstetricia y ginecología. 2016;81(2):99-104.
13. Kobayashi S, Hanada N, Matsuzaki M, Takehara K, Ota E, Sasaki H, et al. Assessment and support during early labour for improving birth outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017(4).
14. Organización Mundial de la Salud - OMS. Declaración de la OMS sobre tasas de cesárea. Resumen ejecutivo Suiza. 2015.
15. Torres J, Díaz J, Gutiérrez M. Mortalidad materna en el Instituto Materno Perinatal en el quinquenio 1991-1995. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. 1997;43(2):152-7.
16. Yábar Peña M. La Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes adolescentes: Características y beneficios integrales. Horizonte Médico. 2014;14:39-44.
17. Cruz AJR, Canales ODM. Los efectos de políticas públicas incoherentes. La relación entre los congresos médicos y el uso discrecional de la cesárea en México. Gestión y Análisis de Políticas Públicas. 2020(24):24-43.
18. Zapata Sandoval DG. Miedo al parto como factor de aumento en el índice de cesáreas. un estudio transversal en el hospital universitario: Universidad Autónoma de Nuevo León; 2020.
19. Déctor-Palma CE, Mera-Hernández CB, Valencia-Medina E, Tejeda-Romero C, González-Aldeco PM. Evaluación de la psicoprofilaxis y del soporte emocional continuo para disminuir el índice de cesáreas. Revista de Sanidad Militar. 2019;73(5-6):303-7.
20. Elizalde Silva E. Estudio comparativo del índice de cesáreas efectuado en el servicio de ginecología y obstetricia del hospital regional de alta especialidad Ixtapaluca vs índice de cesáreas establecido por la OMS a partir de los grupos 1, 2, 6 y 10 de la clasificación de Robson. 2019.
21. Regalado JL. Psicoprofilaxis durante el embarazo para mejorar el proceso y los resultados del trabajo de parto y de las condiciones del recién nacido. Estudio

comparativo en tres centros de salud: Augusto Egas, Los Rosales y la Concordia de la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, durante el periodo 2015: Tesis para segunda especialidad. Pontificia Universidad Católica del Ecuador …; 2017.

22. Coaquira Huanca C. Relación de la psicoprofilaxis obstétrica con los resultados obstétricos, neonatales y en la salud mental perinatal de primigestas en hospitales de la ciudad del Cusco, 2020. 2020.
23. Ocrospoma CRY. Estudio comparativo de los beneficios maternos y perinatales durante el trabajo de parto de pacientes que acudieron y no acudieron al programa de psicoprofilaxis obstétrica del Hospital Nacional Hipólito Unanue, julio-diciembre, Lima; 2017. 2018.
24. Daza Gutierrez M. Características del parto y el recién nacido en parturientas que recibieron psicoprofilaxis obstétrica en el hospital Félix Mayorca Soto, Tarma durante el año 2019. 2021.
25. Mamani Borda AC. Preparación en Psicoprofilaxis Obstétrica y los resultados maternos perinatales en parturientas del centro materno infantil César López Silva. Villa el salvador, lima: septiembre 2017 a septiembre 2018. 2019.
26. Osorio Apcho LU. Efecto de la asistencia a sesiones de psicoprofilaxis obstétrica sobre los indicadores materno-perinatales en pacientes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales de enero a marzo del 2017. 2018.
27. García Paredes V. Influencia de la psicoprofilaxis obstétrica en la prevención de complicaciones maternas y neonatales, de los partos atendidos en el Hospital Regional de Loreto, de enero a diciembre del 2016.
28. Ccanto Moran M. Beneficios de psicoprofilaxis obstétrica durante el trabajo de parto en las primigestas atendidas en el Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica, 2016. 2018.
29. Videla M, Grieco A. Parir y nacer en el hospital: de la psicoprofilaxis obstétrica a la psicoprofilaxis perinatal interdisciplinaria: Ediciones Nueva Visión; 1993.
30. Morales Alvarado S, Guibovich Mesinas A, Yábar Peña M. Psicoprofilaxis Obstétrica: Actualización, definiciones y conceptos. Horizonte Médico. 2014;14(4):53-7.
31. Organización Mundial de la Salud . Guía Técnica para la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación prenatal. normas legales minsa. 2011.

32. Alvarado HSLSM. Impacto de la Psicoprofilaxis Obstétrica en la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Redalyc. 2013;12(2):49-52.
33. Pecho S. Reflexiones acerca de la Estimulación Prenatal (EPN) y el consentimiento informado como indicadores de la calidad de atención en salud. Boletín Científico ASPPO. 2014;16(47):8-9.
34. Carrasco MJS, Hernández HR. Evaluación educativa en el contexto del programa de propedéutico de la Universidad Autónoma Chapingo.
35. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Obstetrícia de Williams-25: McGraw Hill Brasil; 2021.
36. Schwarcz R, Fescina R, Duverges C. Obstetricia. 6ª. Ed Buenos Aires-Argentina: El ateneo. 2009.
37. Cox SM, Casey ML, MacDonald PC. Accumulation of interleukin-1β and interleukin-6 in amniotic fluid: a sequela of labour at term and preterm. Human reproduction update. 1997;3(5):517-27.
38. Ll C. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). Protocolos asistenciales en obstetricia Infección urinaria y embarazo Barcelona: Ediciones Mayo. 2004.
39. Santonja Lucas J. La evolución del parto normal. Cienc ginecol. 2003:378-83.
40. Rigol Ricardo O, Satiesteban Alba S. Obstetricia y ginecóloga. Ciencias Médicas; 2014.
41. Berghella V, Mackeen A, Jauniaux E. Parto por cesárea. Obstetricia: Embarazos normales y de problemas 7ª ed Philadelphia, PA: Elsevier. 2017.
42. Perinatal I. Guías de Práctica Clínica y de Procedimientos en Obstetricia y Perinatología. Lima: INMP. 2014.
43. Gonzales EOV. Beneficios del Contacto Precoz Piel a Piel. Revista de la Federación Centroamericana de Obstetricia y Ginecología. 2019;23(3).
44. Farine D, Shepherd D, Robson M, Gagnon R, Hudon L, Basso M, et al. Classification of caesarean sections in Canada: the modified robson criteria. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada. 2012;34(10):976-9.
45. Zúniga-Briceño AI. Clasificación de cesáreas según el modelo de Robson, unidad obstétrica, Hospital General San Felipe, Honduras, abril-junio de 2017. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 2019;70(1):19-26.

46. Caballero A. Metodología de la investigación científica. Editorial Udegraf SA Lima. 2000.
47. Palomino J, Peña J, Zevallos G, Orizano L. Metodología de la investigación. Guía para elaborar un proyecto en salud y educación Lima: Editorial San Marcos. 2015.
48. Artiles Visbal L, Otero Iglesias J, Barrios Osuna I. Metodología de la Investigación para las Ciencias de la Salud. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. 2009:169-81.
49. Supo JA. Metodología de la Investigación. Bioestadístico. 2012.
50. Sampieri RH. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta: McGraw Hill México; 2018.
51. Sánchez Carlessi H, Reyes Romero C, Mejía Sáenz K. Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística. 2018.
52. Soto A, Cvetkovich A. Estudios de casos y controles. Revista de la Facultad de Medicina Humana. 2020;20(1):138-43.
53. Ybaseta-Soto G, Quijandria-Tataje C, y baseta-Soto M. Parto vaginal en gestantes con cesárea previa en un Hospital General de Perú. Revista Médica Panacea. 2020;9(1):4-12.
54. Smith C, Teng F, Branch E, Chu S, Joseph KS. Maternal and Perinatal Morbidity and Mortality Associated With Anemia in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2019;134(6):1234-44.
55. Echáis JF. Cesárea. Experiencia en el Hospital General de Oxapampa. 2015. 2015;50(2):5.
56. Cuestas Meneses HSEC, Henry Yoler; Valer Carmen, Nashely Sandy. Cesárea previa, legrado uterino y paridad como factores relacionados a la retención de restos placentarios en el puerpetio inmediato, en el servicio gineco-obstetricia del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano durante el año 2012. 2015.

# ANEXOS

# ANEXO A:

## Matriz de consistencia

# RESULTADOS MATERNO PERINATALES E INDICE DE CESAREAS EN PUÉRPERAS CON PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2019

| PROBLEMA | OBJETIVOS | JUSTIFICACIÓN | VARIABLE | DIMENSION | METODOLOGÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Problema general**<br>¿Cuáles son los resultados materno perinatales e índice de cesárea en puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019?<br><br>**Problemas específicos**<br>• ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019?<br>• ¿Cuáles son los resultados materno perinatales en puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019?<br>• ¿Cuál es el grupo de cesáreas más frecuentes en puérperas con y sin | **Objetivo general**<br>Determinar los resultados materno perinatales e índice de cesárea en puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019.<br><br>**Objetivos específicos**<br>• Describir las características sociodemográficas de las puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019.<br>• Determinar los resultados materno perinatales en puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019.<br>• Identificar el grupo de cesárea en puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en | El estudio obedeció a la necesidad de conocer los resultados materno perinatales e índice de cesáreas en puérperas con y sin psicoprofilaxis obstétrica, atenidas en el Hospital Departamental de Huancavelica durante el año 2019.<br>En el Hospital Departamental de Huancavelica, se viene ofertando el servicio de psicoprofilaxis obstétrica desde hace años, cuyos beneficios han sido estudiados; sin embargo, los resultados materno perinatales e índice de cesáreas en este grupo aún se desconocen.<br>Los resultados del presente estudio permitirían ampliar conocimientos actualizados, evitar cesáreas innecesarias, el ahorro de recursos hospitalarios buena administración del tiempo y personal. Además de servir de base para estudios de mayor complejidad. | Resultados materno perinatales<br><br>Índice de Cesárea<br><br>Psicoprofilaxis obstétrica | - Características sociodemográficas<br>- Resultados Materno<br>- Resultado perinatal<br><br>- Clasificación de cesárea según Robson<br><br>- Con participación<br>- Sin participación | **Nivel de investigación**<br>El nivel de investigación es relacional<br><br>**Tipo de investigación**<br>investigación observacional, descriptivo, retrospectivo de corte transversal.<br><br>Diseño de Investigación<br>El estudio corresponde a un diseño descriptivo comparativo, en dos muestras:<br>Esquema:<br>$G_1$ $O_1$ y $O_2$<br>$G_2$ $O_1$ y $O_2$<br><br>$G_1$ = puérperas con PPO<br>$G_2$ = puérperas sin PPO<br>$O_1$ = resultados materno perinatales<br>$O_2$ = índice de cesáreas<br><br>**Población, muestra, muestreo**<br>La población; comprende a todas las puérperas atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica.<br><br>**Muestra:**<br>Clasificados en dos etapas acorde a criterios, siendo elegidos de forma apareada 36 puérperas con psicoprofilaxis obstétrica y 36 sin psicoprofilaxis obstétrica. |

| PROBLEMA | OBJETIVOS | JUSTIFICACIÓN | VARIABLE | DIMENSION | METODOLOGÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| psicoprofilaxis obstétrica, atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019? | el Hospital Departamental de Huancavelica, 2019. | | | | **Muestreo:**<br>No probabilístico intencional<br><br>**Instrumento y técnicas:** ficha de registro y análisis documental.<br><br>**Procesamiento de datos**: se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. |

# ANEXO B:

## Instrumento de recolección de datos

*Universidad Nacional de Huancavelica*
*Segunda especialidad en psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal con adecuación intercultural*

.

## FICHA DE REGISTRO

**Indicaciones:** La presente ficha de registro permite revisar las historias cínicas y demás registros de las puérperas atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica durante el año 2019 con la finalidad de comparar los resultados materno perinatales y el grupo de cesáreas según Robson.
Antes de su llenado, tomar en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.

**Código N° …… -**

Preparación psicoprofilaxis obstétrica: Si ( ) No ( )

**I. Características sociodemográficas**

- Estado civil: Casada ( ) Conviviente ( ) Soltera ( ) Viuda ( )
- Nivel de instrucción: Inicial ( ) Primaria ( ) Secundaria ( )
  Superior No universitario ( ) Superior Universitario ( ) Sin estudios ( )
- Atención prenatal: <4 ( ) 4 a 6 APN ( ) > 6 APN ( )
- Paridad: Primípara ( ) Multípara ( ) Gran multípara ( )
- Espacio intergenésico: Corto ( ) Normal ( ) Largo ( )
- Cesárea previa: Si ( ) No ( )
- Edad gestacional al momento del parto: < 37 semanas ( ) 37-41ss ( ) >41ss( )

**II. Cesárea**

**Tipo de parto:**

Vaginal ( ) Cesárea ( )

**Si culminó en cesárea, cuál fue la indicación ……..marque el grupo al que corresponde:**

| GRUPOS | MARCAR |
|---|---|
| 1. Mujeres nulíparas con embarazo simple, feto en cefálica, EG mayor o igual a 37 semanas en trabajo de parto espontáneo. | |
| 2. Mujeres nulíparas con embarazo simple, feto en cefálica, EG mayor o igual a 37 semanas a quienes se les realizó inducción del trabajo de parto o se les practicó cesárea antes del trabajo de parto | |
| 3. Mujeres multíparas sin cicatriz uterina previa, con un embarazo simple, feto en cefálica, EG mayor o igual a 37 semanas y trabajo de parto espontáneo | |
| 4. Mujeres multíparas sin cicatriz uterina previa, con un embarazo simple en cefálica, EG mayor o igual a 37 semanas y se les realizó inducción del trabajo de parto o se les practicó cesárea | |
| 5. Todas las mujeres multíparas con antecedente de al menos una cicatriz uterina, feto en cefálica, con EG mayor o igual a 37 semanas | |

| | |
|---|---|
| 6. Todas las nulíparas con embarazo simple en presentación podálica | |
| 7. Todas las multíparas con embarazo simple, en presentación podálica, con o sin antecedente de cicatriz uterina | |
| 8. Todas las mujeres con embarazo múltiple, con o sin antecedente de cicatriz uterina. | |
| 9. Todas las mujeres con embarazo simple, en situación transversa u oblicua, con o sin antecedente de cicatriz uterina. | |
| 10. Todas las mujeres con embarazo simple, feto en cefálica, EG de 36 semanas o menos, con o sin antecedente de cicatriz uterina | |

**III. Resultados materno perinatal**

**Resultado materno**

- Inicio del parto: espontáneo ( ) acentuación ( ) inducido ( ) cesárea programada ( )
- **Periodos**
  - 1° periodo " dilatación": dilatación retenida" ( ) dilatación normal ( ) dilatación acelerada ( )
  - 2° periodo " expulsivo": Expulsivo prolongado ( )

- **Complicaciones**

  Preeclampsia SI ( ) No ( )

  Macrosomía fetal SI ( ) No ( )

  **Otros : ……**

**Resultado perinatal**

- Situación transversa: Si ( ) No ( )
- Presentación: Cefálica ( ) Podálica ( )
- Numero de fetos: Simple ( ) Doble ( )
- Peso del Neonato Bajo peso ( ) normal ( ) macrosómico ( )
- Apgar al minuto: 0-3 ( ) 4-6 ( ) 7-10 ( )
- Contacto piel a piel: Si ( ) No ( ) No registra ( )

# ANEXO C:

## Validación del instrumento de investigación

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA**
**(Creada por Ley 25265)**
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

## Ficha de evaluación del instrumento de investigación por el criterio de experto o Juez

**Instrumento:** Ficha de registro.

**Investigación:** Resultados materno perinatales en puérperas pos cesárea con psicoprofilaxis obstétrica atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica.

## 1. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y nombres del Juez : _____
1.2. Grado académico : _____
1.3. Mención : _____
1.4. DNI/ Celular : _____
1.5. Cargo e institución donde labora : _____
1.6. Lugar y fecha : _____

## 2. ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN

| INDICADORES | CRITERIOS | DEFICIENTE | BAJA | REGULAR | BUENA | MUY BUENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. CLARIDAD | Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible. | | | | | |
| 2. OBJETIVIDAD | Permite medir hechos observables. | | | | | |
| 3. ACTUALIDAD | Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. | | | | | |
| 4. ORGANIZACIÓN | Presentación ordenada. | | | | | |
| 5. SUFICIENCIA | Comprende aspectos de las variables en cantidad y calidad suficiente. | | | | | |
| 6. PERTINENCIA | Permite conseguir datos de acuerdo a los objetivos planteados. | | | | | |
| 7. CONSISTENCIA | Pretende conseguir datos basado en teorías o modelos teóricos. | | | | | |
| 8. COHERENCIA | Entre variables, dimensiones, indicadores e ítems. | | | | | |
| 9. METODOLOGÍA | La estrategia responde al propósito de la investigación. | | | | | |
| 10. APLICACIÓN | Los datos permiten un tratamiento estadístico pertinente. | | | | | |
| | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| **CONTEO TOTAL DE MARCAS** (realice el conteo en cada una de las categorías de la escala) | | A | B | C | D | E |
| | | | | | | |

**CALIFICACIÓN GLOBAL:** Coeficiente de validez $= \frac{1\,x\,A + 2\,x\,B + 3\,x\,C + 4\,x\,D + 5\,x\,E}{50}$

$= \text{-----}$

**3. OPINIÓN DE APLICABILIDAD** (Ubique el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y marque con un aspa en el círculo asociado).

| CATEGORÍA | | INTERVALO |
|---|---|---|
| No válido, reformular | ◯ | [0,20 – 0,40] |
| No válido, modificar | ◯ | <0,41 – 0,60] |
| Válido, mejorar | ◯ | <0,61 – 0,80] |
| Válido, aplicar | ◯ | <0,81 – 1,00] |

**4. RECOMENDACIONES:**

……
……
……
……
……
……

……..
Firma del Juez

turnitin

# CERTIFICADO DE SIMILITUD

**Por medio del presente y de acuerdo al siguiente detalle:**

- Trabajo de investigación, titulado:

  **"RESULTADOS MATERNO PERINATALES E INDICE DE CESAREAS EN PUÉRPERAS CON PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, 2019"**

- presentado por:
  **LAURENTE ARANA, Roxana**
  **QUIÑONEZ INGA, Magally**

- Docente asesor (a):
  **Dra. MUÑOZ DE LA TORRE, Rossibel Juana**

- Para obtener:
  El Título de Especialista en: **PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA Y ESTIMULACIÓN PRENATAL CON ADECUACIÓN INTERCULTURAL**

La Unidad de Promoción, Difusión y Repositorio, certifica **que el presente trabajo de investigación,** se encuentra dentro del porcentaje permitido de coincidencia por la Universidad Nacional de Huancavelica.

Por tanto, en cumplimiento del Art.4° del Reglamento del Software Anti plagio de la Universidad Nacional de Huancavelica, se dictamina que el trabajo de investigación fue analizado por el software anti plagio TURNITIN (realizado por el docente Asesor), se expide el presente.

| ORIGINALIDAD | SIMILITUD |
|---|---|
| 85.0 % | 15.0 % |

El Certificado se expide el 12 de setiembre del año 2023.

Nº 203-2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y REPOSITORIO

MSC. YOVANA QUISPE PAYTAN
JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y REPOSITORIO